Université Paris Cité

Déterminants de santé
Facteurs comportementaux

Pr. Corinne Alberti
Unité d'Épidémiologie Clinique
Hôpital Universitaire Robert Debré

Année universitaire 2026-2027

Université Paris Cité

Objectifs pédagogiques : sensibiliser aux principaux déterminants liés aux comportements, à leurs conséquences sanitaires et aux actions de prévention à mener

Conduites addictives
- Alcool
- Tabac

Activité physique et sédentarité

Nutrition

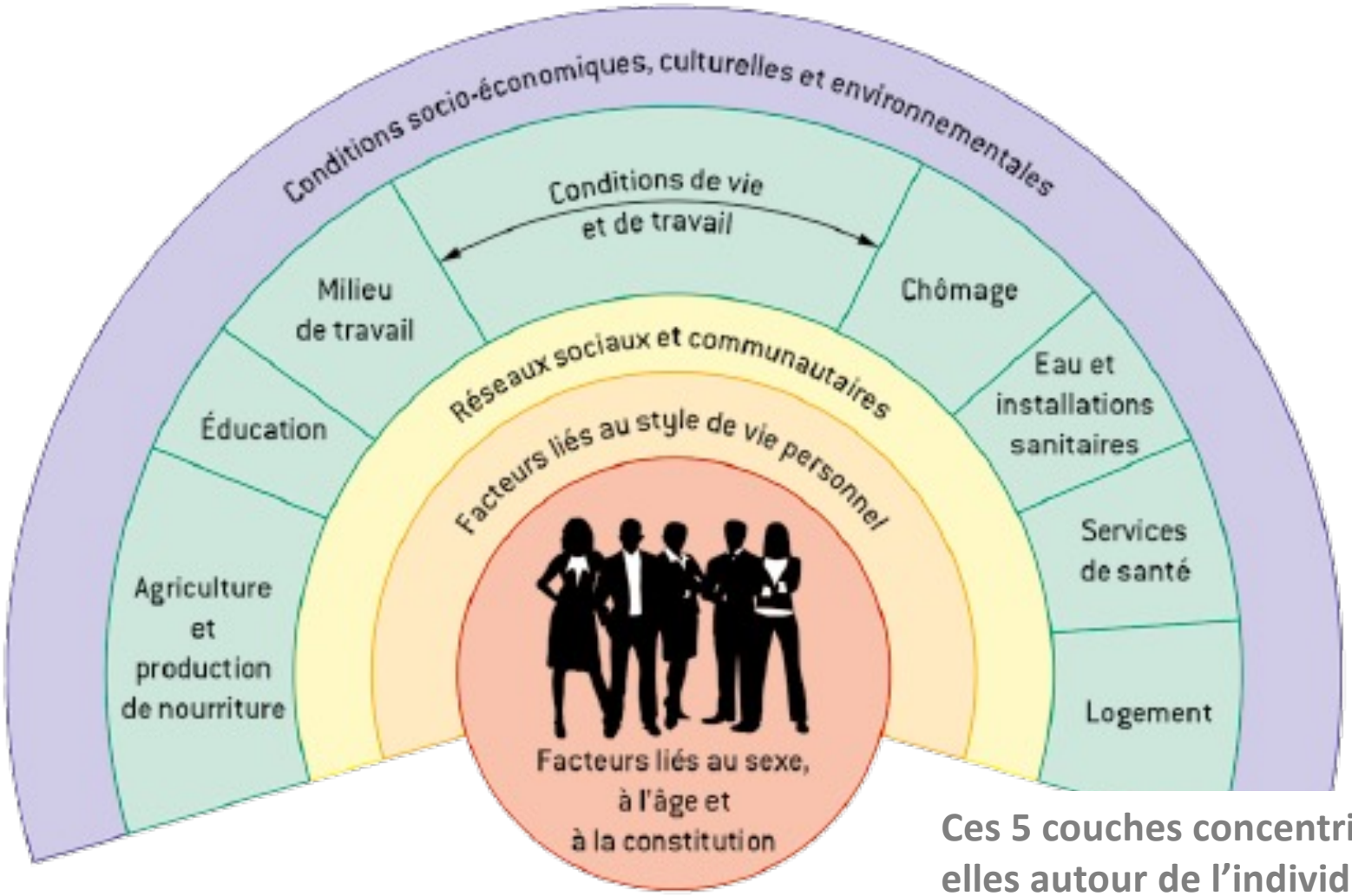
Santé sexuelle

Université Paris Cité

Déterminants de la santé

Facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations.

Ils **influencent** l'état de santé, **ou y sont associés,** interagissent entre eux et engendrent des conditions de vie qui influent sur la santé.



Modèle de Dahlgren and Whitehead 1991

Facteurs exogènes

Environnement au sens large
Conditions de vie
Conditions socio-économiques, culturelle, environementales

Facteurs endogènes modifiables

Style de vie, réseaux sociaux et communautaires

Facteurs endogènes non modifiables

Age, sexe
Génétique

Ces 5 couches concentriques interagissent entre elles autour de l'individu

Tableau 16 de l'annexe Charge majeure de morbidité – facteurs de risque et maladies/traumatismes occupant les 10 premiers rangs, pays développés, 2000

Pays développés à mortalité très faible ou faible chez l'enfant (Amr-A, Eur-A, Eur-B, Eur-C, PacO-A)

Année de Vie corrigée du facteur d'Invalidité

Facteurs de risque	% des AVCI
Tabagisme	12,2
Hypertension	10,9
Alcool	9,2
Hypercholestérolémie	7,6
Surcharge pondérale	7,4
Apport insuffisant en fruits et légumes	3,9
Sédentarité	3,3
Usage de drogues illicites	1,8
Pratiques sexuelles à risque[a]	0,8
Carence en fer[b]	0,7

Maladies/traumatismes	% des AVCI
Cardiopathie ischémique	9,4
Dépression unipolaire majeure	7,2
Maladie cérébrovasculaire	6,0
Troubles liés à la consommation d'alcool	3,5
Démence et autres troubles du système nerveux central	3,0
Surdité	2,8
Bronchopneumopathie obstructive chronique	2,6
Accidents de la circulation	2,5
Arthrose	2,5
Cancers de la trachée/des bronches/du poumon	2,4

[a] La charge morbide résultant des pratiques sexuelles à risque est due au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles.
[b] La charge morbide résultant de la carence en fer est due aux causes maternelles et périnatales ainsi qu'aux effets directs de l'anémie.

Fraction attribuable en population 1-24 %
Fraction attribuable en population 25-49 %
Fraction attribuable en population >50 %

10 FACTEURS PRINCIPAUX

Université Paris Cité

Déterminants de la mortalité prématurée évitable

Facteurs de risque comportementaux

Tabac, Alcool, Substances addictives, Nutrition, Sédentarité, Sexualité, comportements routiers …

Facteurs potentiellement modifiables, accessibles aux modifications des modes de vie, en vue d'un effet positif sur la santé

Ils constituent un ensemble de comportement et de pratiques, souvent répétitives qui sont susceptibles de mettre en danger les individus sur les plans physique, psychologique ou social

Université Paris Cité

Fardeau des principaux facteurs de risque comportementaux

Addictions : tabac, alcool

Exercice physique et sédentarité

Nutrition

Comportements routiers *(cf. cours prévention)*

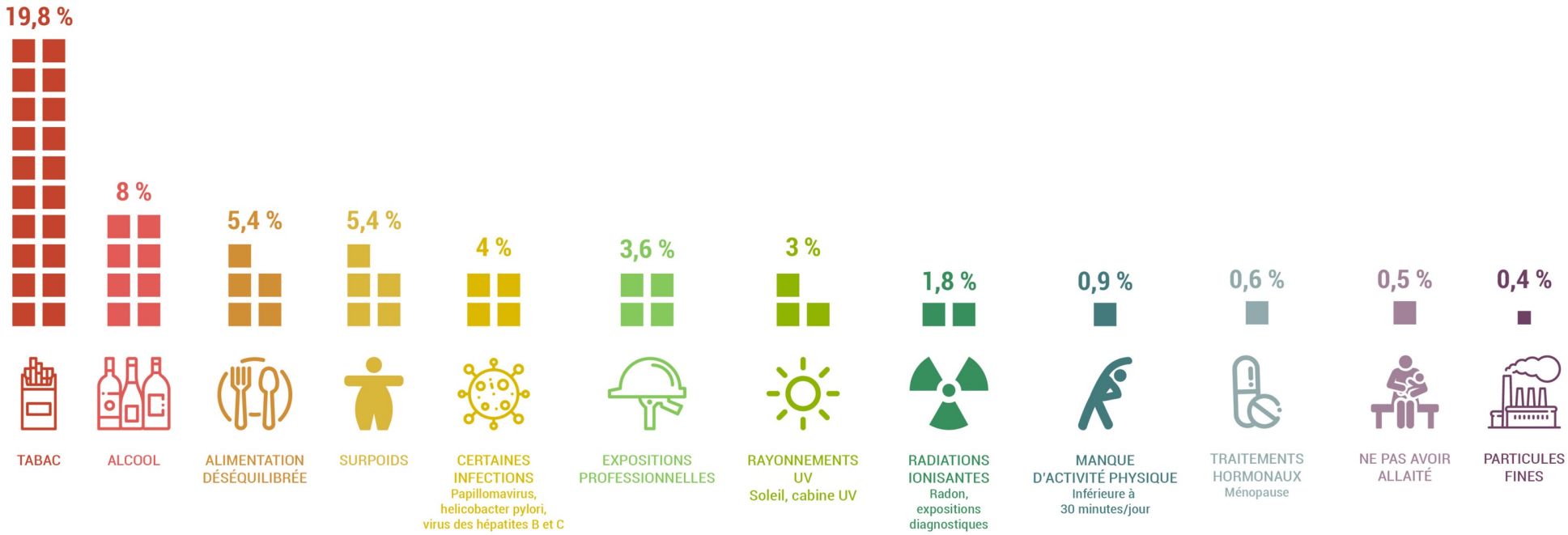
Santé sexuelle

Université Paris Cité

Proportion des cancers liés aux principaux facteurs de risque

On peut prévenir 40 % des cas de cancers (142 000/an) grâce à des changements de comportements et des modes de vie

(Source : CIRC / INCa 2018)



Université Paris Cité

Addictions

L'OMS donne la définition suivante : ***« l'addiction est un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou des comportements »***

Les addictions concernent le **tabac** (nicotine), **l'alcool**, le **cannabis**, les **opiacés** (héroïne, morphine), la **cocaïne**, les **amphétamines** et **dérivés de synthèse**.

Parmi les **addictions sans substance** sont reconnus cliniquement comme une dépendance comportementale dans les classifications diagnostiques internationales le jeu pathologique - jeux de hasard et d'argent (**gambling disorders**) et les jeux vidéo (**gaming disorders**)

Université Paris Cité

Addictions – Classification internationale

Notions de perte de contrôle de soi, Interférence de la consommation sur les activités scolaires ou professionnelles, Poursuite de la consommation malgré la conscience des troubles provoqués …

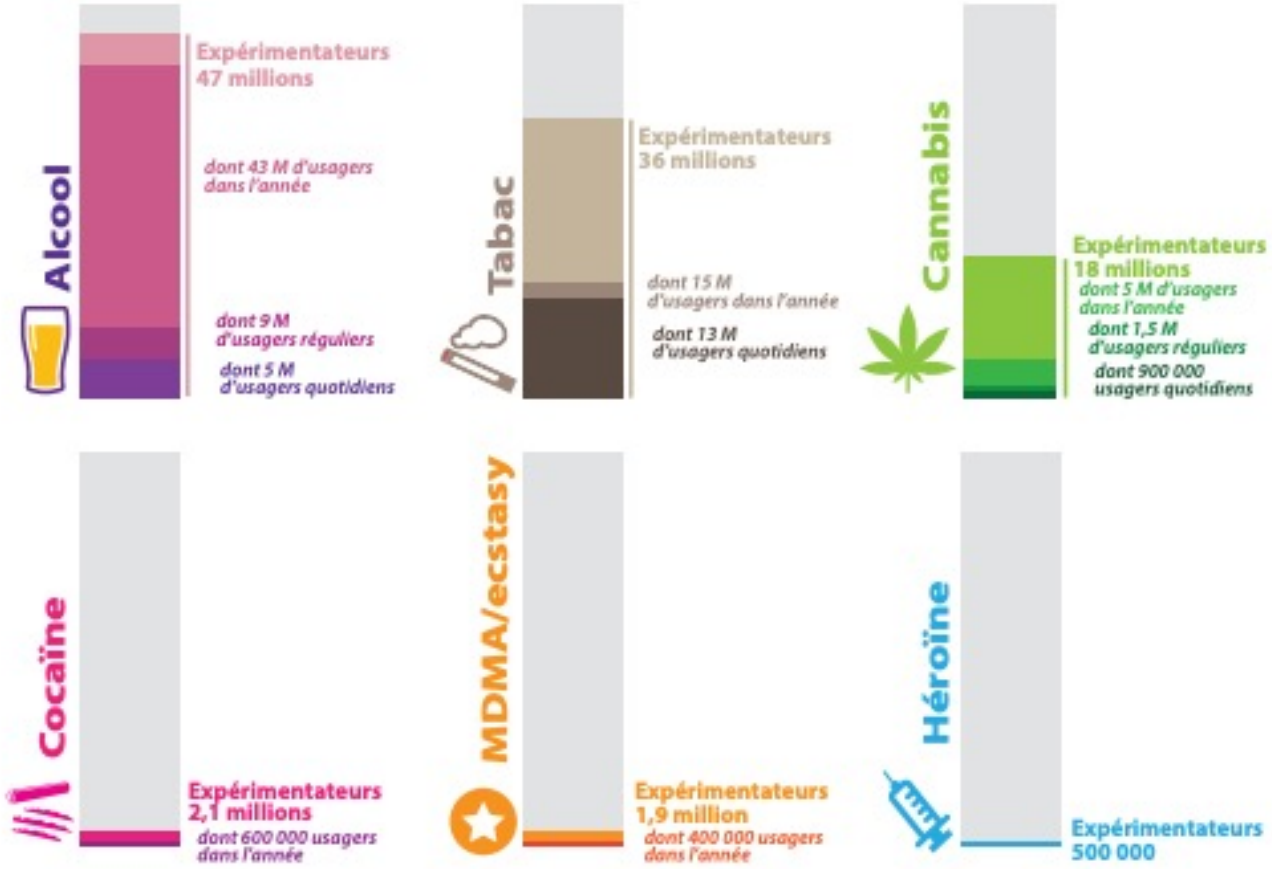
(Les critères sont donnés à titre indicatif)

Les 6 critères de la dépendance de la Classification Statistique internationale des maladies de l'OMS (CIM 10)

Pour faire ce diagnostic, au moins 3 des manifestations suivantes doivent avoir été présentes en même temps, au cours de la dernière année :

1. Un désir puissant ou compulsif d'utiliser une substance psychoactive ;
2. difficultés à contrôler l'utilisation de la substance (début ou interruption de la consommation ou niveaux d'utilisation) ;
3. syndrome de sevrage physiologique quand le sujet diminue ou arrête la consommation d'une substance psychoactive, comme en témoignent la survenue d'un syndrome de sevrage caractéristique de la substance ou l'utilisation de la même substance (ou d'une substance apparentée) pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage ;
4. mise en évidence d'une tolérance aux effets de la substance psychoactive : le sujet a besoin d'une quantité plus importante de la substance pour obtenir l'effet désiré ;
5. abandon progressif d'autres sources de plaisir et d'intérêts au profit de l'utilisation de la substance psychoactive, et augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer, ou récupérer de ses effets ;
6. poursuite de la consommation de la substance malgré ces conséquences manifestement nocives. On doit s'efforcer de préciser si le sujet était au courant, ou s'il aurait dû être au courant, de la nature et de la gravité des conséquences nocives

Estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives en France métropolitaine parmi les 11-75 ans [1, 2, 3]



Sources : Baromètre Santé 2017 (SpF) [1], ESCAPAD 2017 (OFDT) [2], EnCLASS 2018 (OFDT) [3]

NB : la population française âgée de 11 à 75 ans est d'environ 50,9 millions (INSEE, 2019).
Ces chiffres sont des ordres de grandeur et doivent être lus comme des données de cadrage. En effet, une marge d'erreur existe, de l'ordre de plus ou moins 5 %. Par exemple, « 18 millions d'expérimentateurs de cannabis » signifie que le nombre d'expérimentateurs se situe vraisemblablement entre 17 et 19 millions.

Université Paris Cité

Tabac

La fumée de tabac est un **aérosol (**mélange de gaz et de particules). Ce mélange se forme à une température pouvant atteindre 1 000° à 1 500 °C. Quand la fumée se forme, les 2 500 composés chimiques contenus dans le tabac non brûlé passent à plus de 4 000 substances dont beaucoup sont toxiques.

On retrouve dans la fumée toujours la nicotine, les goudrons et les agents de saveur mais aussi des **gaz toxiques** (monoxyde de carbone, oxyde d'azote, acide cyanhydrique, ammoniac) et des **métaux lourds** (cadmium, plomb, chrome, mercure).

La **nicotine** est la substance (un alcaloïde puissant) qui entraîne la dépendance. Celle-ci est très forte : elle apparaît dès les premières semaines d'exposition et pour une faible consommation de tabac.



Université Paris Cité

Prévalence du tabagisme en France

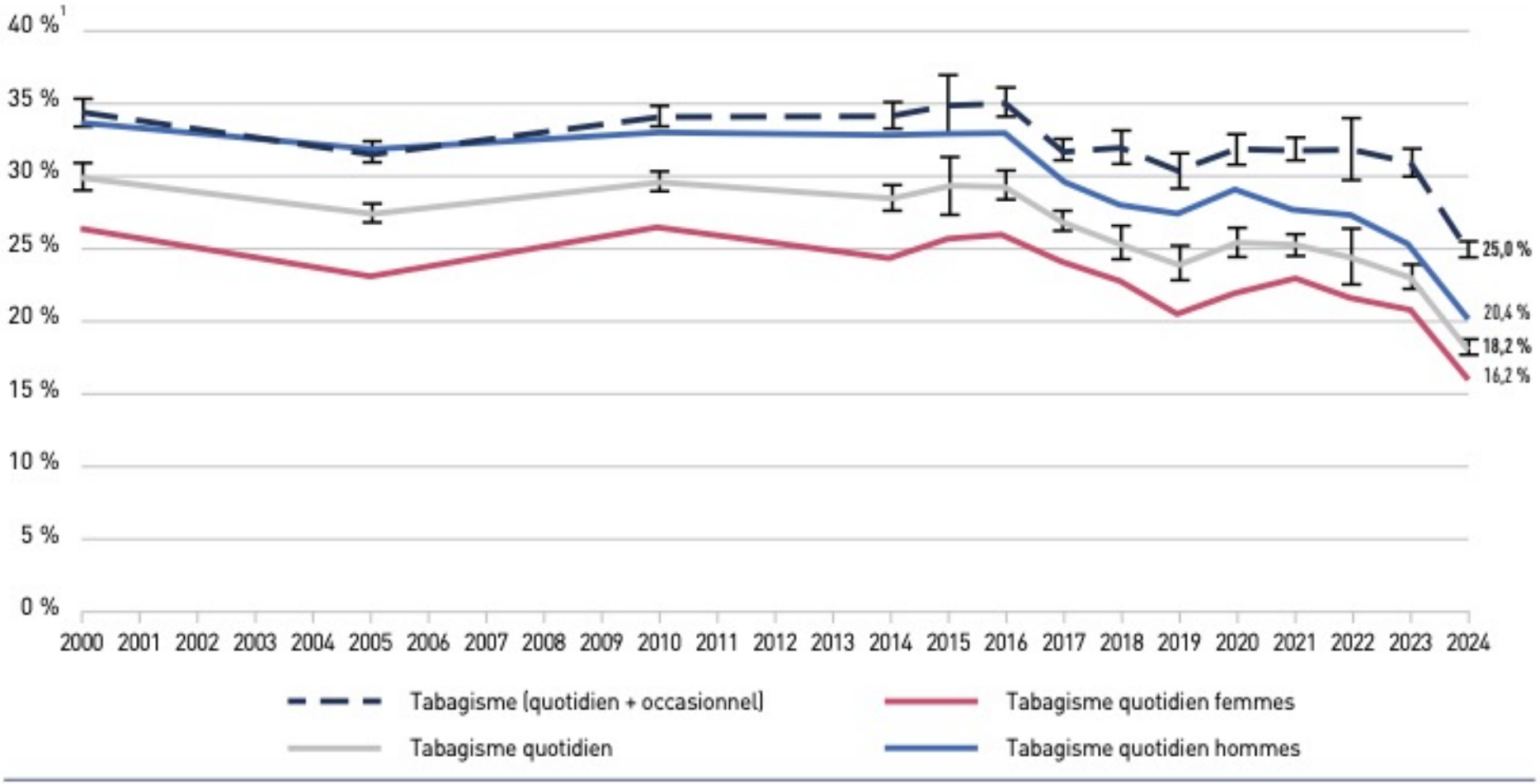
Le tabac, première cause de mortalité évitable en France

Résultats de l'enquête 2024 SPF et OFDT
(Santé Publique France et Observatoire français des drogues et des tendances addictives)

- 25% de fumeurs et 18% de fumeurs quotidiens parmi les 18-75 ans, soit une baisse conséquente (31% et 23% en 2023 respectivement)

- Les hommes fument plus que les femmes (20,4% versus 16,2% quotidiennement) parmi les 18-75 ans

FIGURE 3 | Évolutions de la prévalence du tabagisme et du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les 18-75 ans en France hexagonale



1. Pourcentages pondérés et intervalles de confiance à 95 %.

Sources : Baromètre de Santé publique France, éditions 2000-2024, excepté pour 2015 : Baromètre Cancer INCa-SpF et pour 2023 : Enquête EROPP de l'OFDT.

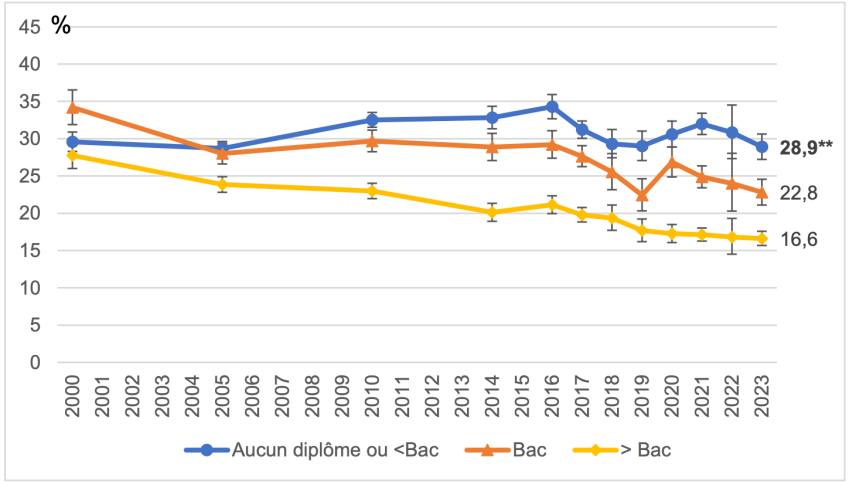
Champ commun entre les différentes enquêtes : adultes âgés de 18 à 75 ans résidant en France hexagonale.

Tabagisme : influence des inégalités sociales

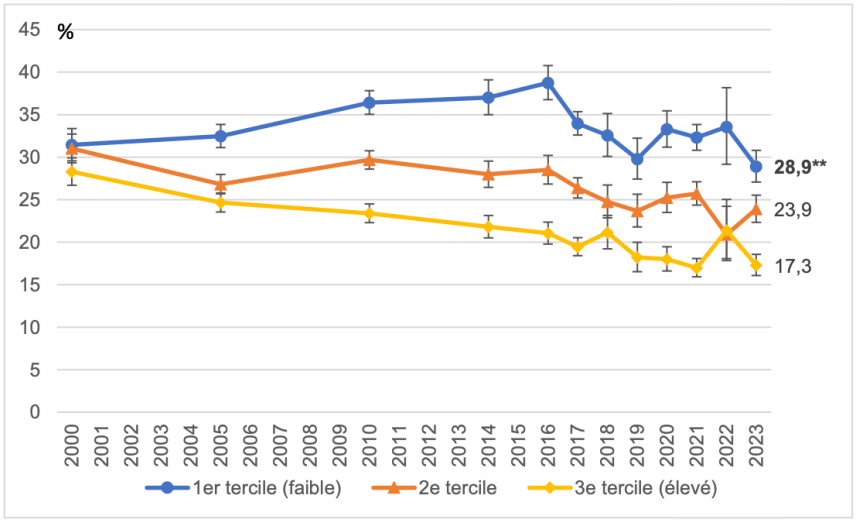
Des inégalités persistantes mais aussi une baisse du tabagisme dans les classes les défavorisées

Figure 2. Evolution de la prévalence du tabagisme quotidien en France hexagonale selon le niveau de diplôme (18-75 ans), le niveau de revenu (18-75 ans) et la situation professionnelle (18-64 ans), et comparaisons entre 2021 et 2023.

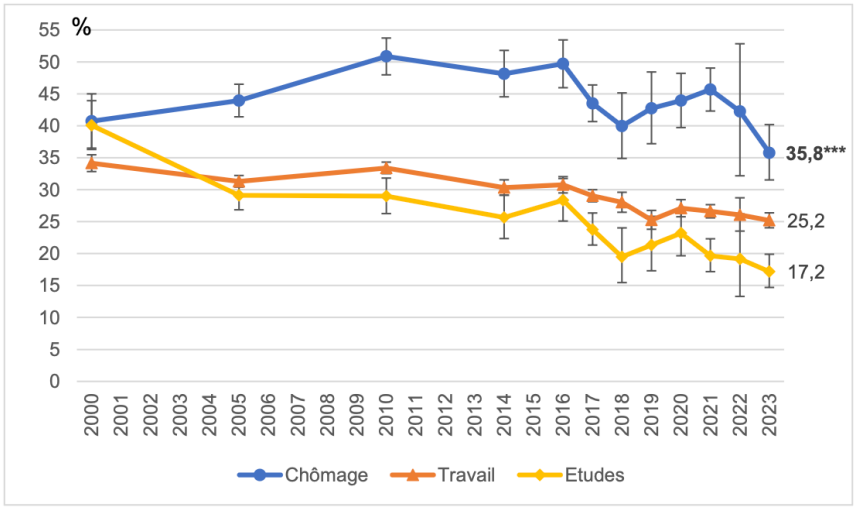
2a : selon le diplôme



2b : selon le revenu mensuel par unité de consommation

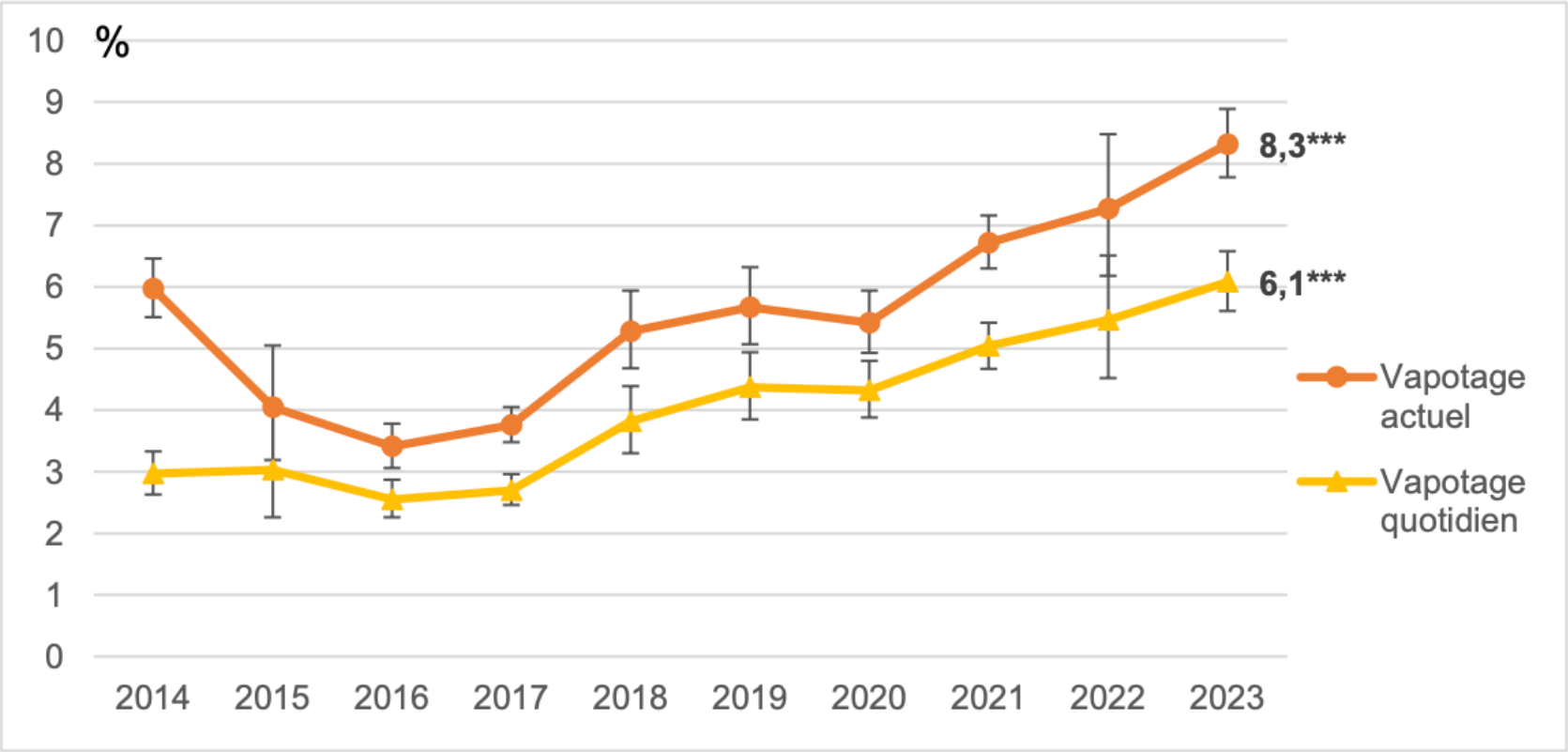


2c : selon le statut vis-à-vis de l'emploi



Source : Baromètres de Santé publique France 2000-2022, Enquête EROPP 2023 OFDT- exploitation Santé publique France.

Figure 3. Evolution de la prévalence du vapotage et du vapotage quotidien en France hexagonale parmi les 18-75 ans et comparaisons entre 2021 et 2023

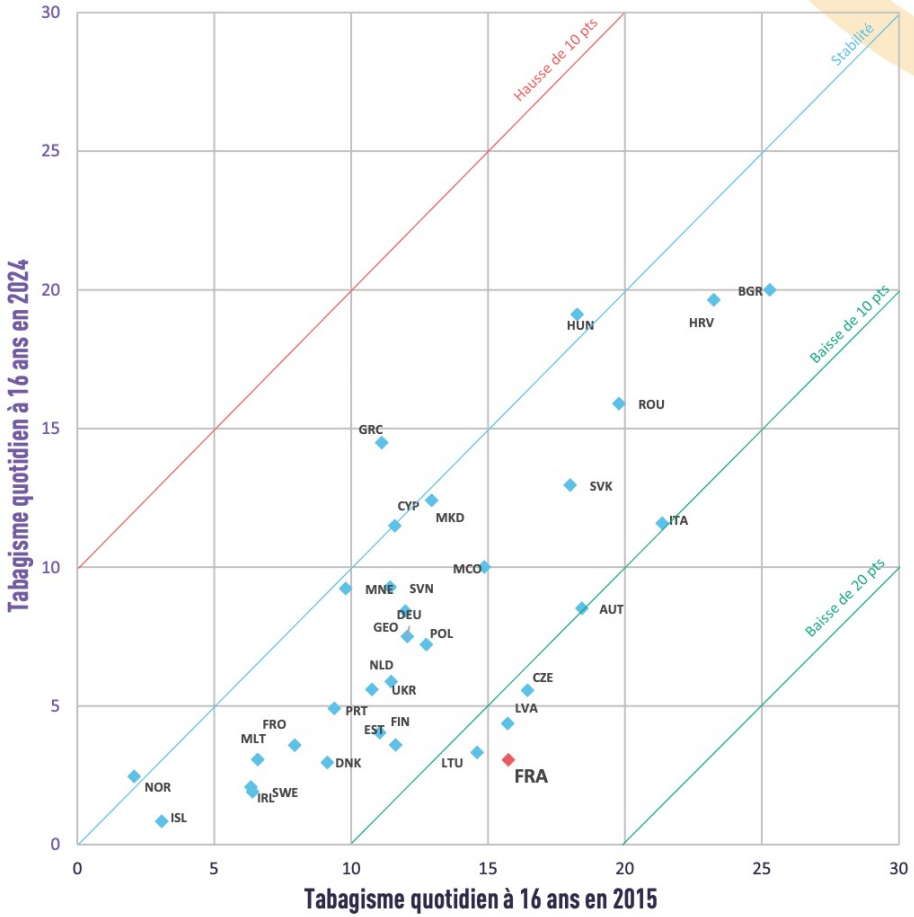


Source : Baromètres de Santé publique France 2000-2022, excepté 2015 Baromètre Cancer INCa-SpF, Enquête EROPP 2023 OFDT-exploitation Santé publique France.

Tabagisme chez les jeunes

Une réduction spectaculaire en France avec une expérimentation concernant moins de 20% des jeunes de 16 ans, soit le niveau le plus bas en Europe

Figure 1. Évolution des niveaux d'usage quotidien de cigarettes de tabac à 16 ans en Europe entre 2015 et 2024 (%)



Sources : ESPAD 2015-2024, EnCLASS 2024, exploitation OFDT

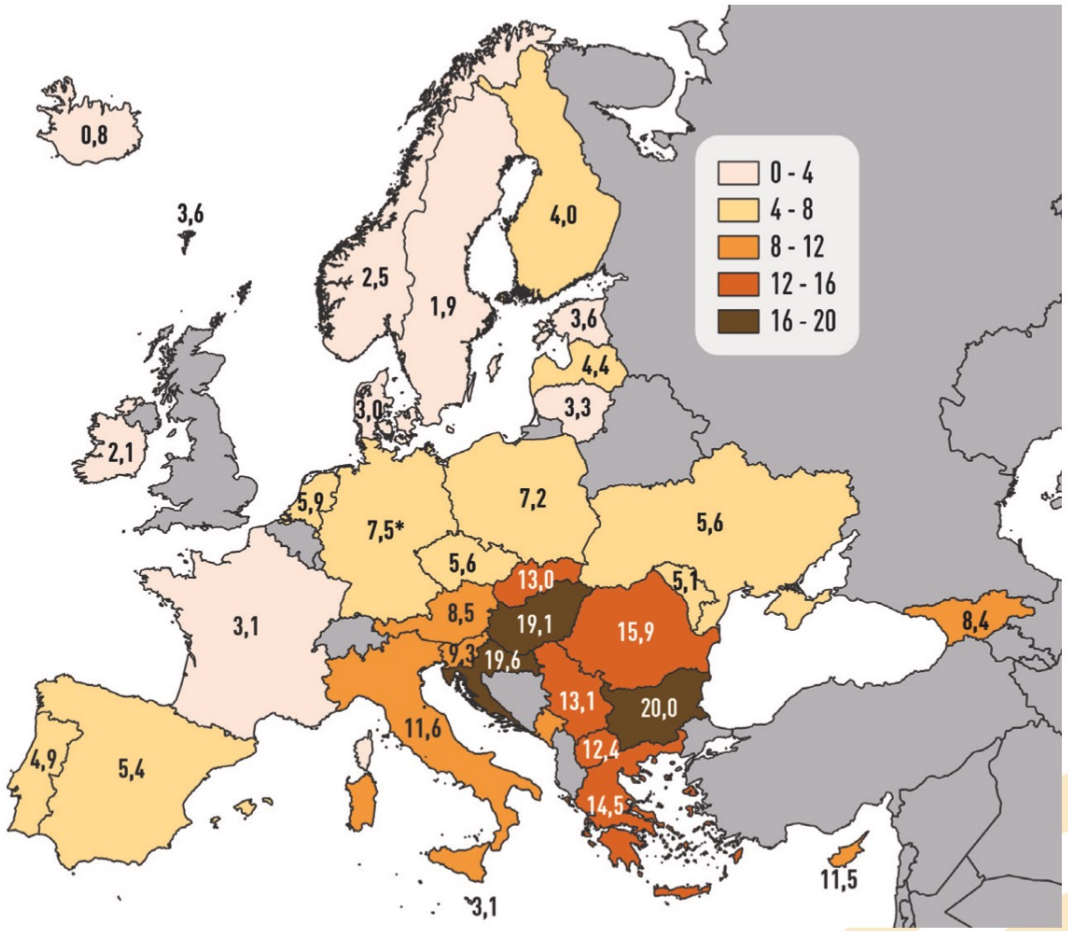
Note de lecture : les prévalences de l'année 2015 sont représentées en abscisse du graphique et celles de 2024 en ordonnée. La position des pays de part et d'autre des traits en diagonale indique l'évolution de l'indicateur : plus le point est situé en haut à gauche, plus l'indicateur a augmenté sur les dix dernières années. À l'inverse, plus il se situe en bas et à droite, plus il a baissé sur la période.

Voir encadré « Repères méthodologiques » p. 8, pour les codes pays ISO (alpha-3) des pays.

Tabagisme chez les jeunes

Une réduction spectaculaire en France avec une expérimentation concernant moins de 20% des jeunes de 16 ans, soit le niveau le plus bas en Europe

Carte 2. Niveaux d'usage quotidien de cigarettes de tabac à 16 ans en 2024 en Europe (%)



Sources : ESPAD 2024, EnCLASS 2024, exploitation OFDT

Université Paris Cité

Dans le monde

Jha P, Peto R. ***N Engl J Med*** 2014;370:60-68.

On estime qu'au XXe siècle, il y a eu **100 millions de morts liées au tabac**, pour la plupart dans les pays industrialisés.
Si les tendances actuelles persistent, le tabac **va tuer 1 milliard de personnes au XXIe siècle**, pour la plupart dans les pays pauvres ou émergents, et la moitié de ces morts va survenir avant 70 ans

Une cause majeure de décès, de maladie et d'appauvrissement

L'épidémie de tabagisme est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale. Elle fait plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde. Sur ces 8 millions, 7 millions sont dus à la consommation directe de tabac, et quelque 1,3 million sont des non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée du tabac (1).

OMS 31 juillet 2023

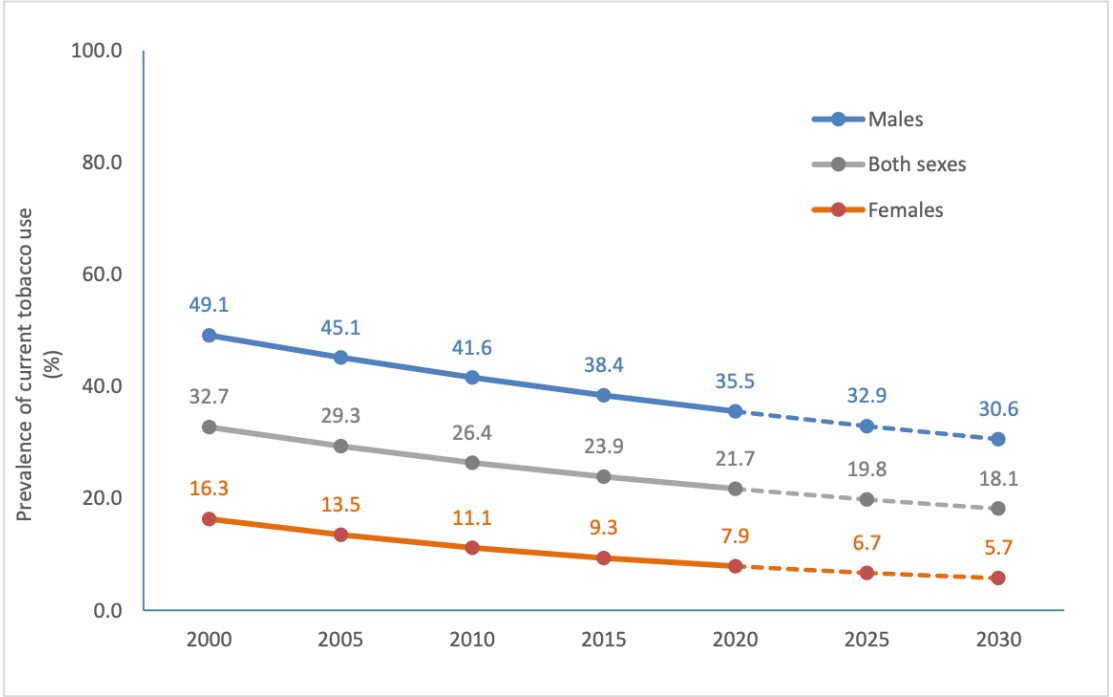
Sur 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, plus de 80 % vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (2), là où la charge de morbidité et de mortalité liées au tabac est la plus lourde. Le tabagisme contribue à la pauvreté, car les ménages dépensent en tabac des sommes qu'ils auraient pu consacrer à des besoins essentiels tels que l'alimentation et le logement. Ces habitudes de consommation sont difficiles à modifier, compte tenu de la dépendance créée par le tabac.

Les coûts économiques du tabagisme sont considérables : il s'agit à la fois des coûts substantiels qu'entraîne le traitement des maladies causées par le tabagisme et du capital humain perdu à cause de la morbidité et de la mortalité imputables au tabac.

Université Paris Cité

Dans le monde

Fig. 2: Global trends in prevalence of tobacco use among people aged 15 years and older, by sex, 2000–2030 (estimates to 2020, projections to 2030)



Université Paris Cité

Fig. 3: Global trends in age pattern of tobacco use among males, 2000–2030 (estimates to 2020, projections to 2030)

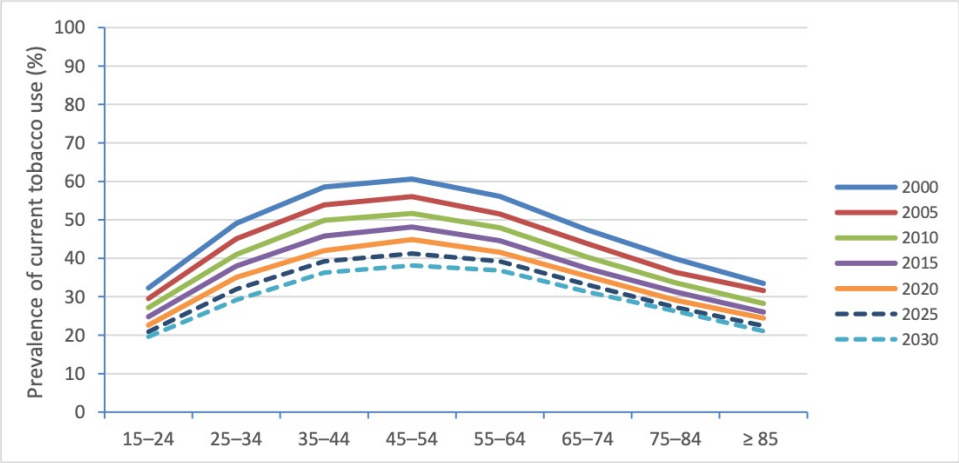


Fig. 4: Global trends in age pattern of tobacco use among females, 2000–2030 (estimates t 2020, projections to 2030)

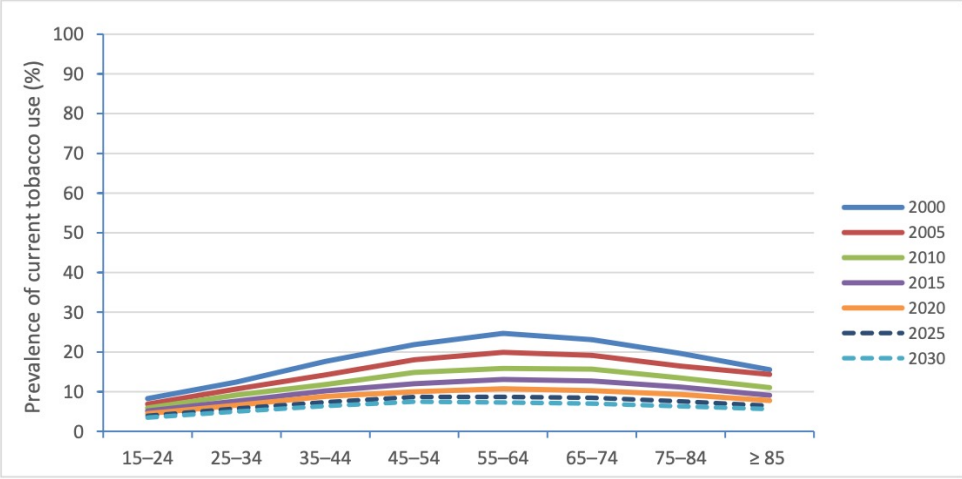
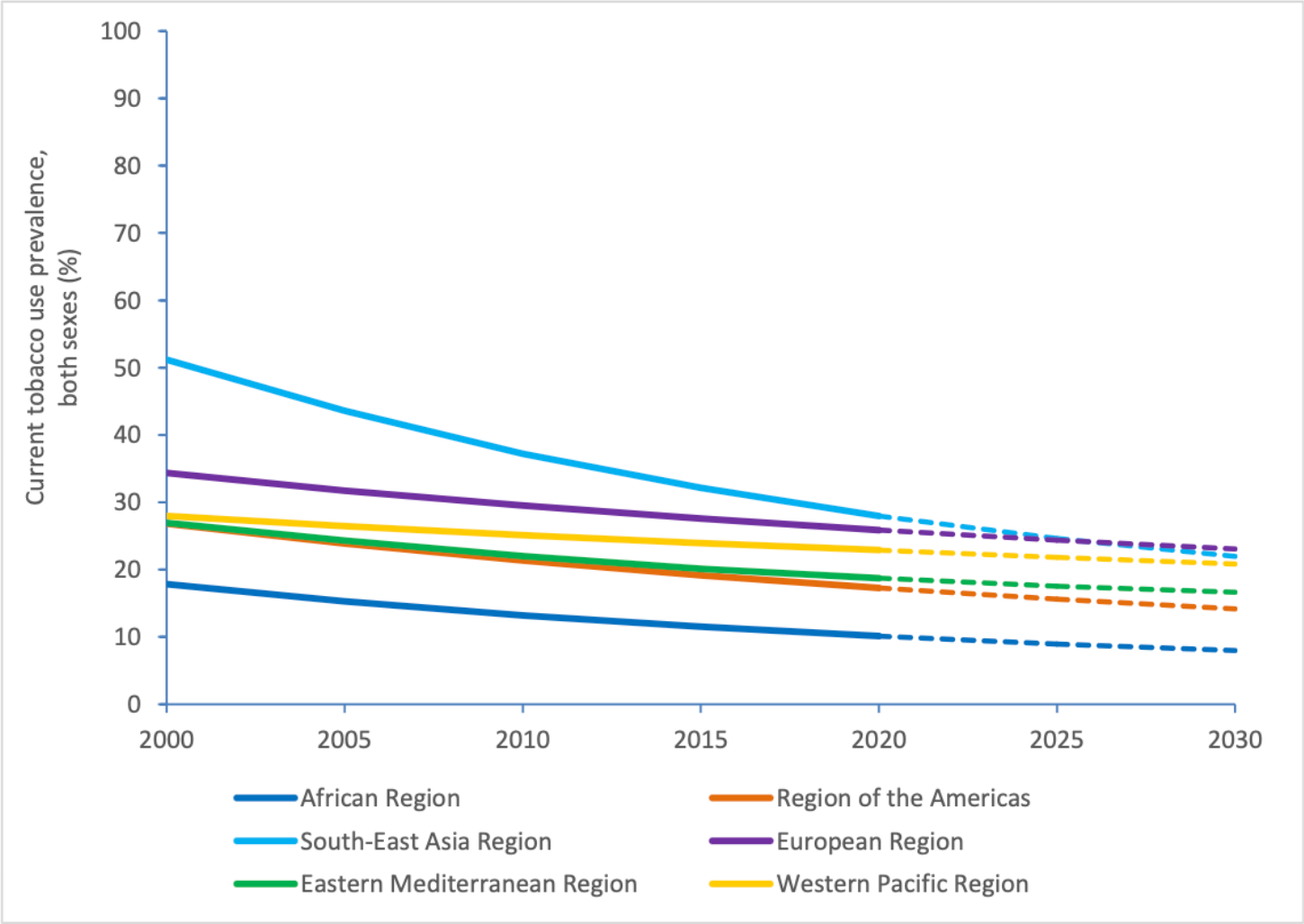


Fig. 5: Trends in current tobacco use among both sexes combined aged 15 years and older, WHO region averages, 2000–2030 (estimates to 2020; projections to 2030)



Université Paris Cité

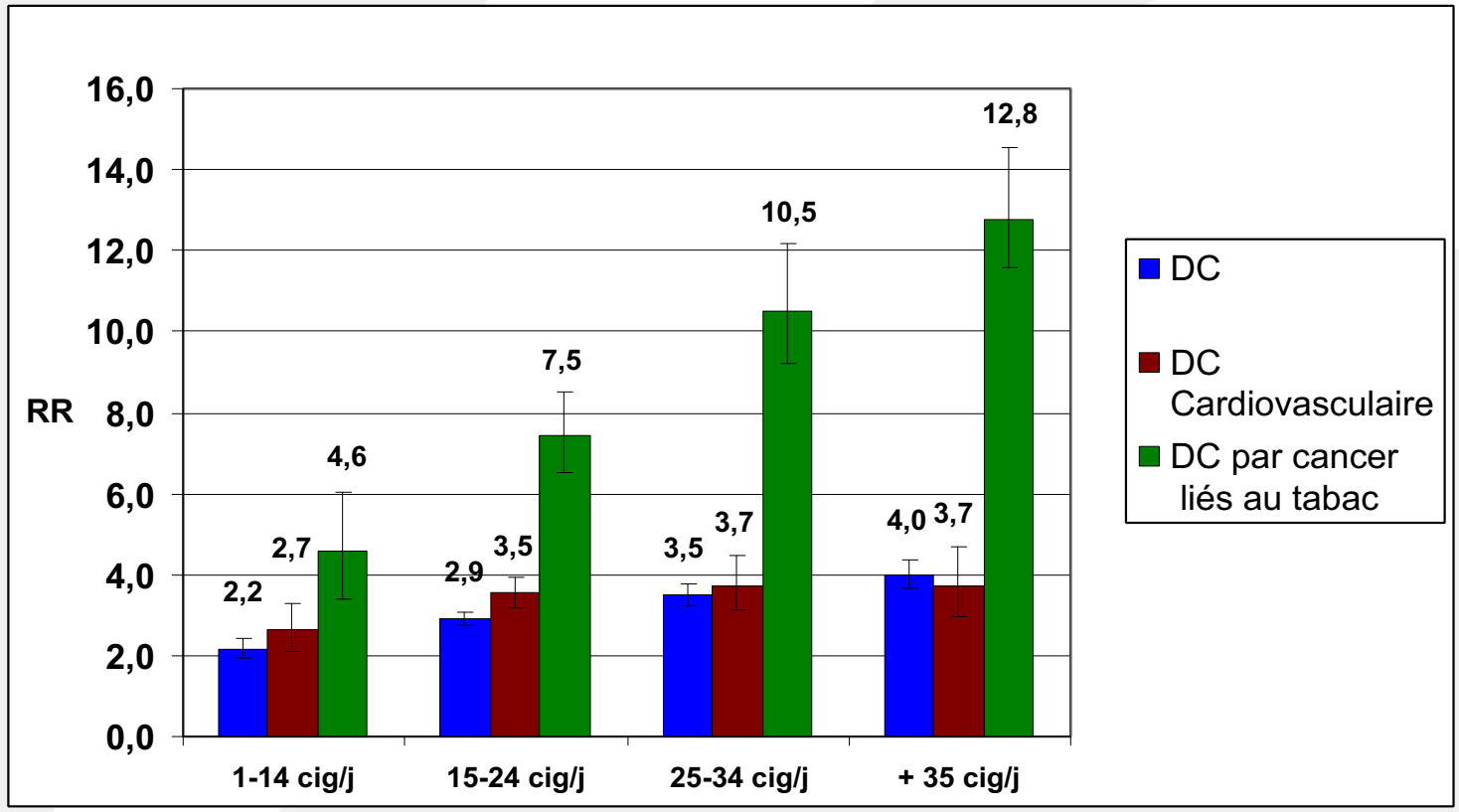
Conséquences sanitaires

Tabagisme actif

- Infections bronchiques, asthme
- Cancers : 1 cancer sur 3 est lié au tabagisme, principalement le poumon mais aussi gorge, bouche, pancréas, rein, vessie, utérus.
- Maladies cardio-vasculaires

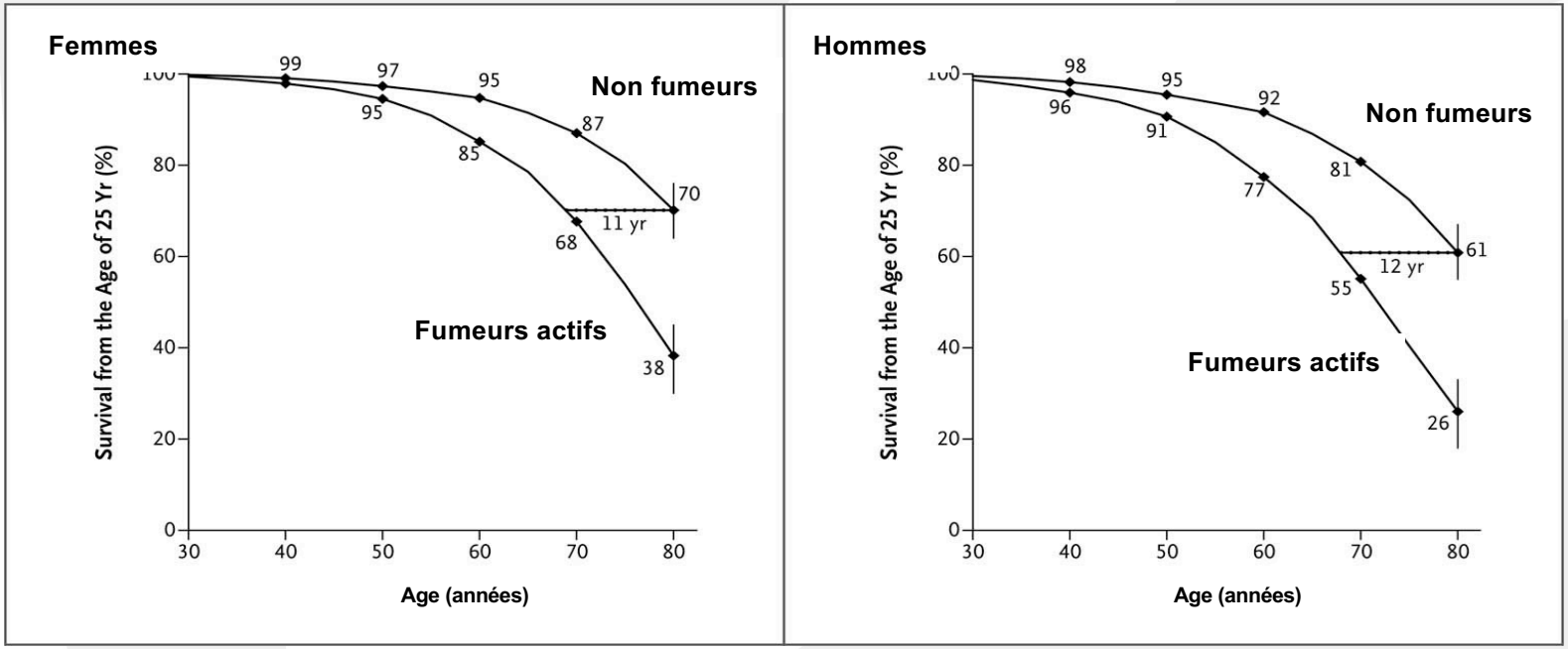
Risque de mortalité globale et de cause spécifique selon la sévérité du tabagisme

Risque relatif de décès comparé aux non-fumeurs



Kenfield et *al* - JAMA. 2008;299:2037-2047

Probabilités de survie pour les fumeurs et les non-fumeurs entre 25 et 80 ans



Par rapport aux sujets n'ayant jamais fumé, les fumeurs actifs perdent au moins une décennie (11 ans pour les femmes et 12 ans pour les hommes) d'espérance de vie à partir de l'âge de 25 ans.

Non-fumeurs: les sujets qui n'ont jamais fumé

Jha P et al. ***N Engl J Med*** 2013;368:341-350

Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

Tabagisme actif

- Bronchopathie Chronique Obstructive (BPCO), insuffisance respiratoire chronique
- Grossesse : responsable de 35% des GEU, augmente le risque de fausse couche par 3, accouchement prématurée, augmentation du délai de conception
    - **Il n'y a pas de seuil en-dessous duquel fumer ne représente pas de risque**

Université Paris Cité

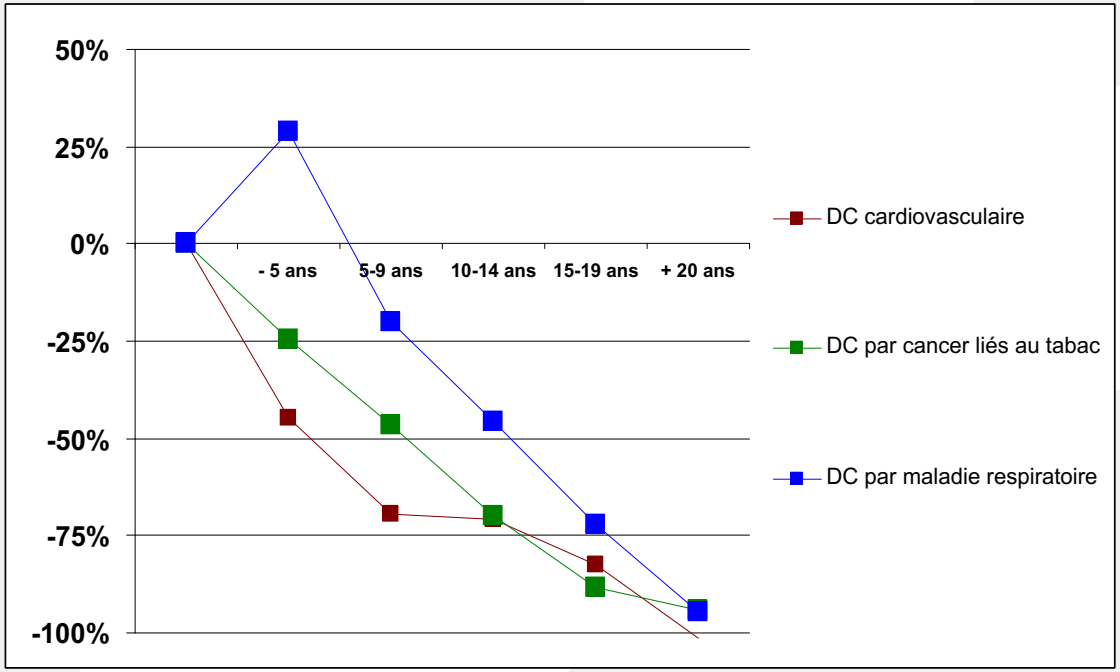
Conséquences sanitaires

Tabagisme passif

- **Sur le fœtus : petits poids de naissance, mort fœtale in utero, malformations congénitales, diminution des capacités cognitives**
- Sur le nourrisson et jeune enfant : mort subite du nourrisson, asthme, infections respiratoires
- Sur l'adulte : cancer du poumon, des sinus, pathologies cardio-vasculaires

Arrêter, c'est utile !

Diminution du risque de mortalité globale et de cause spécifique associé à la durée du sevrage tabagique



Le risque de décès CV diminue le plus rapidement, le risque de cancer également.
Le risque de décès par maladie respiratoire diminue le plus lentement

Augmentation initiale apparente de la mortalité par maladie respiratoire, liée à un effet de « causalité inverse »: c'est parce que les patients sont mourants qu'ils arrêtent de fumer, et non l'inverse

Kenfield et *al* - ***JAMA***. 2008;299:2037-2047

Université Paris Cité

Lutte contre le tabagisme : plus de 40 ans d'histoire

- **1976 – Loi Veil** : interdiction partielle de la publicité et du sponsoring sportif
- **1991 – Loi Evin** : interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
- **2012 : la Cour des comptes** pointe l'insuffisance des politiques publiques
- **2014-2019 – Plan cancer 3** : 17 priorités dont la numéro 10 concerne la lutte contre le tabagisme
- **2014-2019 - Plan National de Réduction du Tabagisme** : 3 axes et 10 mesures
  - Protéger les jeunes
  - Aider les fumeurs à arrêter
  - Agir sur l'économie du tabac (contrebande, buralistes)
- **Adhésion de la France à la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac**
- **Décret n° 2016-1671 du 5/12/2016 - Fonds de lutte contre le tabac** : prélèvement d'un % sur la distribution du tabac en France
- **2018-2022 - Programme National de Lutte contre le Tabac** (dans priorité Prévention)
- **2023-2027 - Programme National de Lutte contre le Tabac**

La lutte anti-tabac en France

Interdiction de fumer | Mention sur les paquets | Interdiction légale

But : inciter les 16 millions de fumeurs français à cesser de fumer

En novembre, on arrête ensemble.

1976 Loi Veil
- «Abus dangereux»
- Lieux publics où fumer peut avoir des «conséquences dangereuses pour la santé»
- Parrainage de compétition sportive

1991 Loi Evin
- Transports et locaux à usage collectif (sauf «zones fumeurs»)
- Vente aux mineurs
- Publicité

2005 «Fumer tue»
- Messages alertant sur la toxicité du tabac

2007
- Tous lieux publics

2010
- **Images chocs** (poumons noircis, dents abîmées...)

2014
Apparition des paquets neutres
- Parcs avec jeux pour enfants
- Voitures avec à bord des enfants de -12 ans

1er jan 2017
Vente obligatoire de paquets neutres

Nov 2017
2e édition du «mois sans tabac»

2020
Paquet de cigarettes à 10 €



Photo AFP/ L. Venance

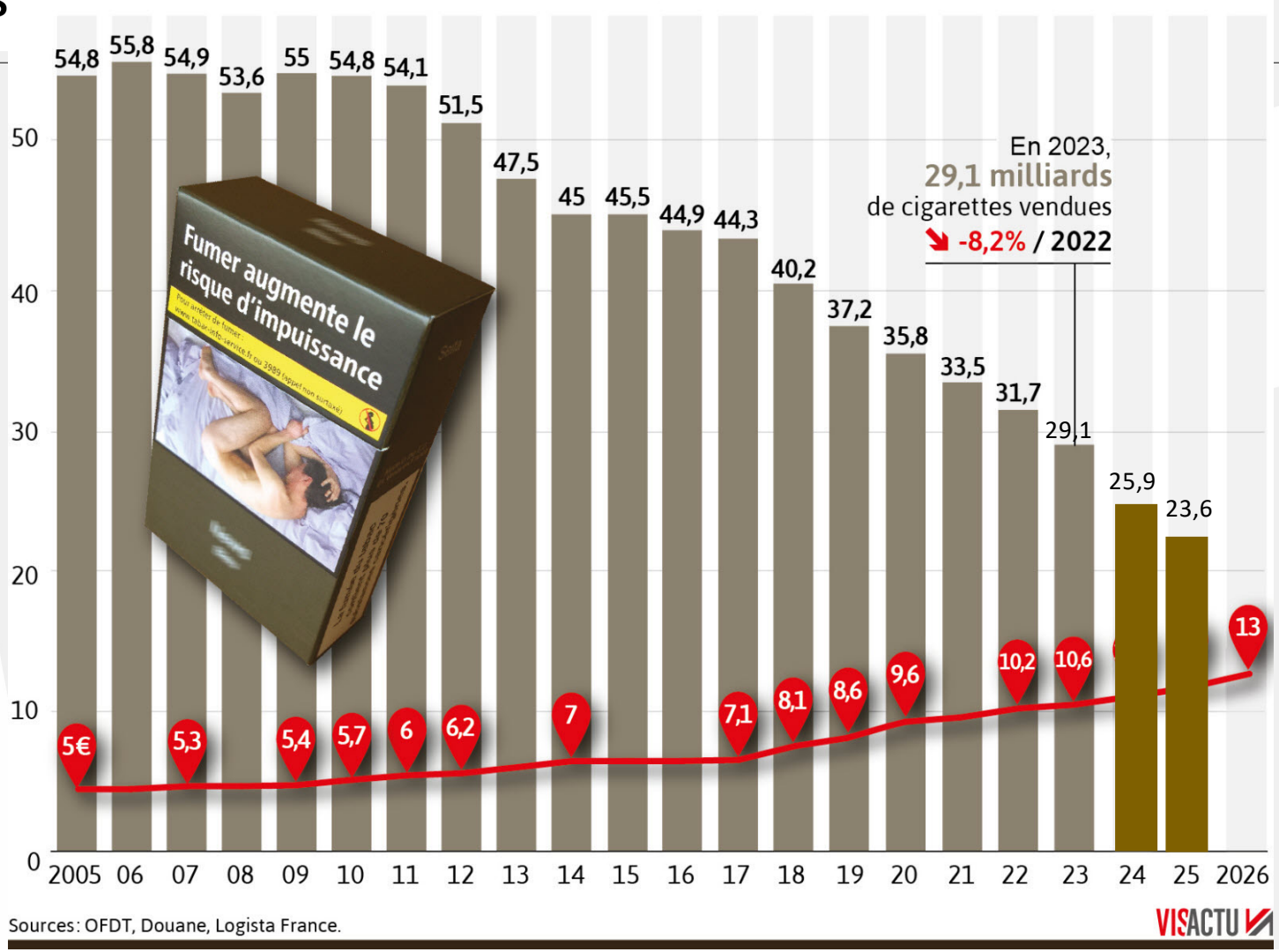
© AFP *Source : ministère de la Santé*

Univ
Paris

Cigarettes: les ventes et le prix du paquet en France

Cigarettes vendues (en milliards), en France métropolitaine

Prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes, en euros, TTC.



Sources: OFDT, Douane, Logista France.

VISACTU

Université Paris Cité

Alcool
= Ethanol



L'alcool est ancré dans la culture française. Sa consommation reste une source importante de mortalité et de morbidité en France.

L'alcool, produit psychoactif, a des effets immédiats qui dépendent surtout de l'alcoolémie mais également des effets à long terme même en cas de faible consommation.

Université Paris Cité

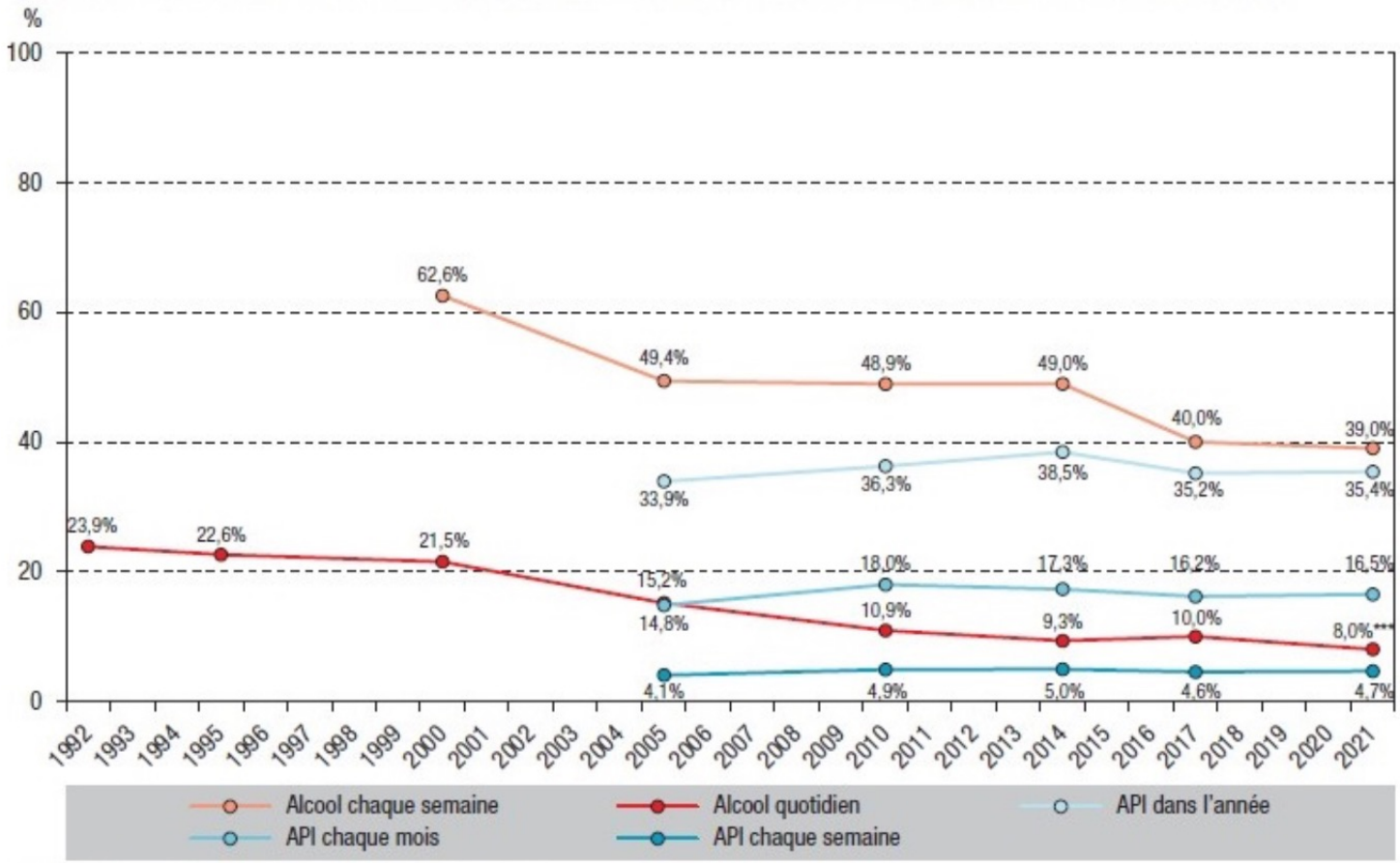
Consommations en France – représentations sociales

Baromètre SPF-2017

- près d'un Français sur deux (49 %) pense qu'offrir de l'alcool ou en boire « *fait partie des règles du savoir-vivre* ».
- motivations à consommer de l'alcool : le goût (80 %) , l'idée de fêtes mieux réussies (56 %), pour la sensation qu'il procure (52 %), pour s'intégrer dans un groupe apprécié (34%), **avoir une alimentation équilibrée (20%) (!!!)**
- 12 % des consommateurs réguliers déclarent boire, car ils n'arrivent pas à s'en passer, traduisant ainsi une dépendance engendrée par l'alcool
- 11,7 litres par an et par personne de 15 ans et plus



Evolution des indicateurs de consommation d'alcool entre 1992 et 2021 en France hexagonale parmi les 18-75 ans



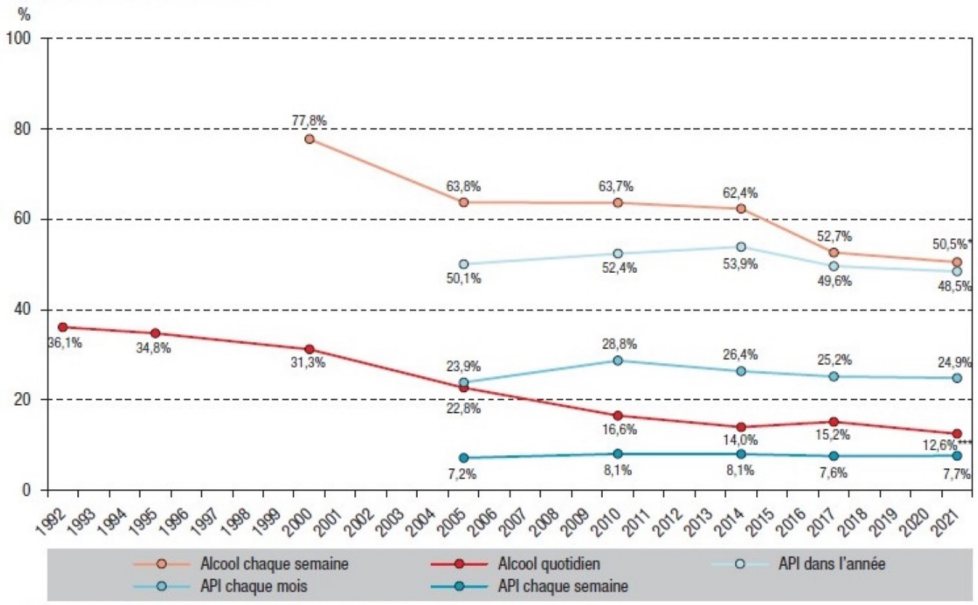
*** : p<0,001 (évolution significative entre 2017 et 2021).
API : alcoolisation ponctuelle importante.

Source : Baromètre de Santé publique France 2021

Université Paris Cité

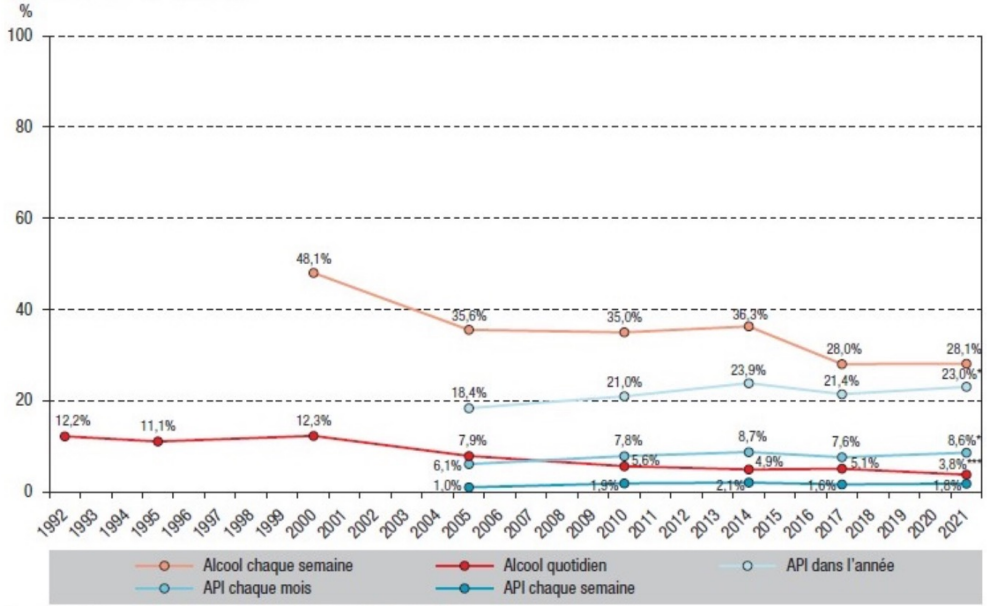
Hommes - Femmes

Evolution des indicateurs de consommation d'alcool entre 1992 et 2021 en France hexagonale parmi les hommes de 18-75 ans



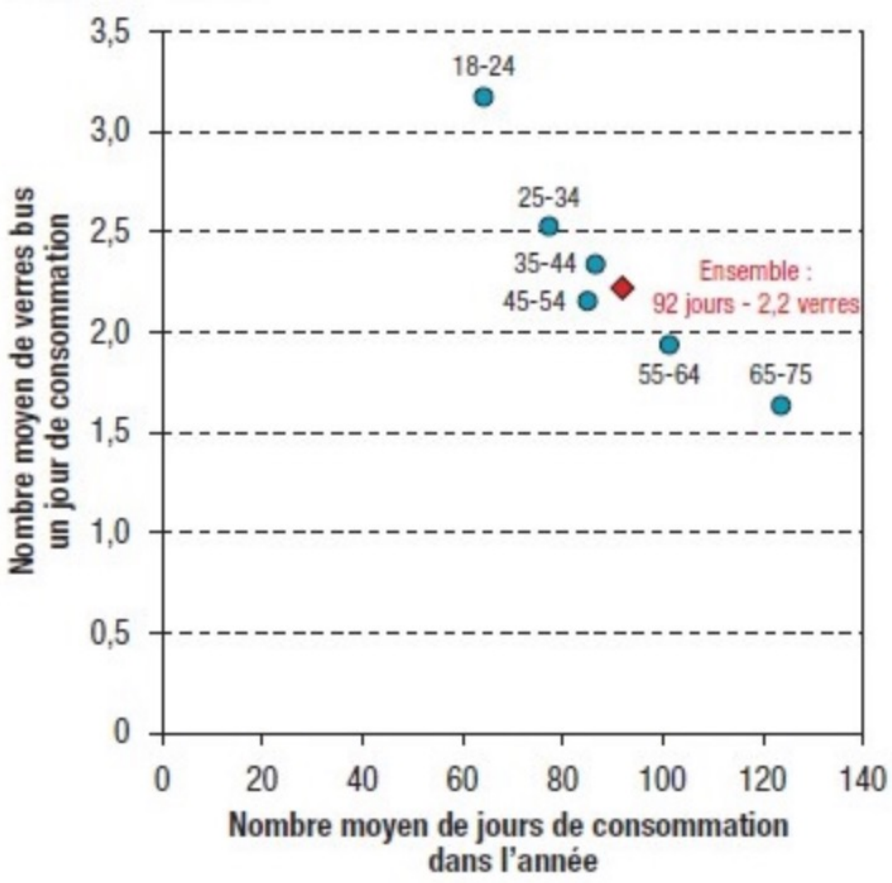
* : p<0,05 ; *** : p<0,001 (évolution significative entre 2017 et 2021).
API : alcoolisation ponctuelle importante.

Evolution des indicateurs de consommation d'alcool entre 1992 et 2021 en France hexagonale parmi les femmes de 18-75 ans

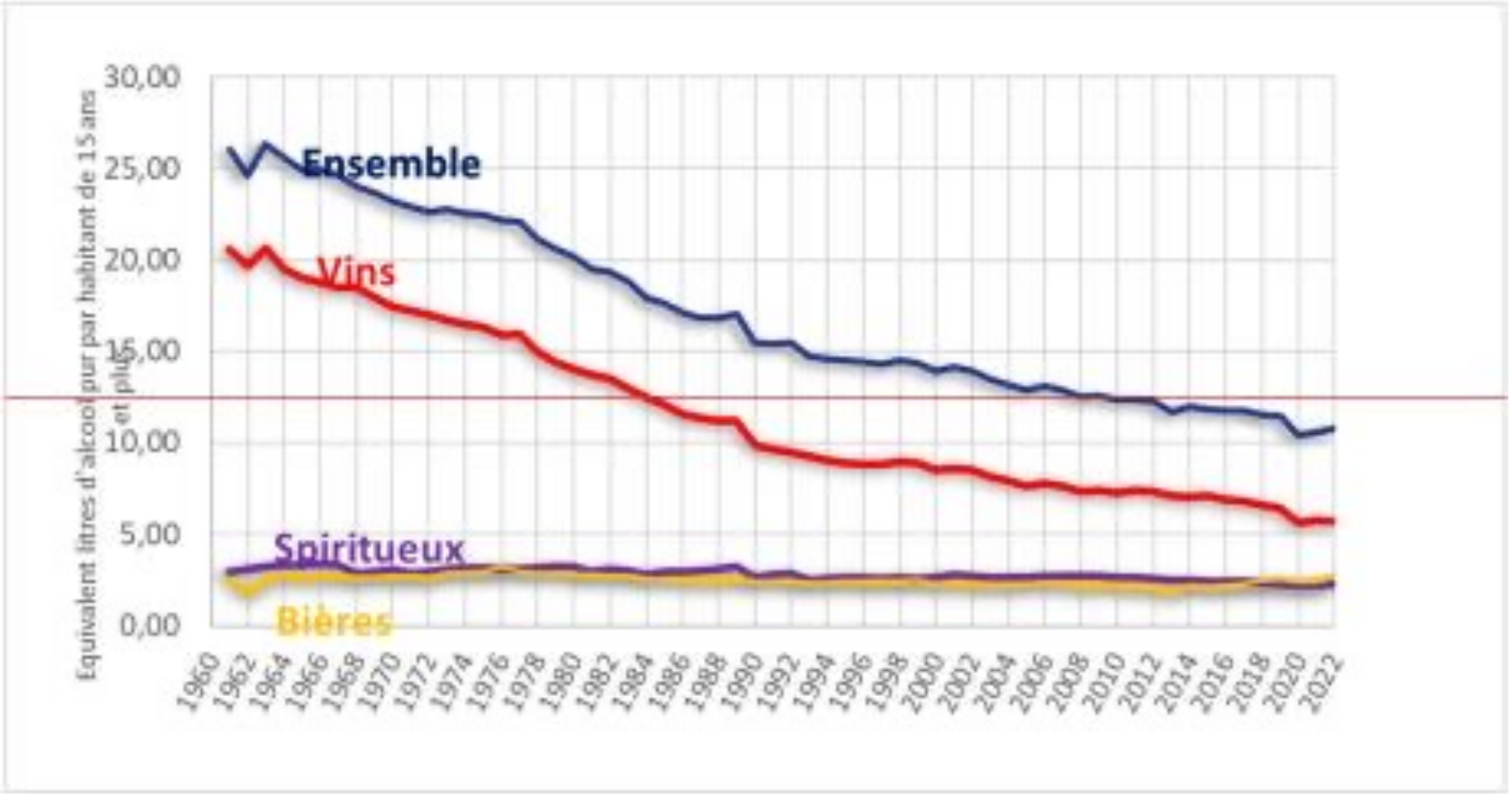


* : p<0,05 ; *** : p<0,001 (évolution significative entre 2017 et 2021).
API : alcoolisation ponctuelle importante.

Distribution des moyennes du nombre de verres d'alcool consommés et du nombre de jours de consommation d'alcool selon l'âge, parmi les 18-75 ans ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois en France hexagonale, 2021

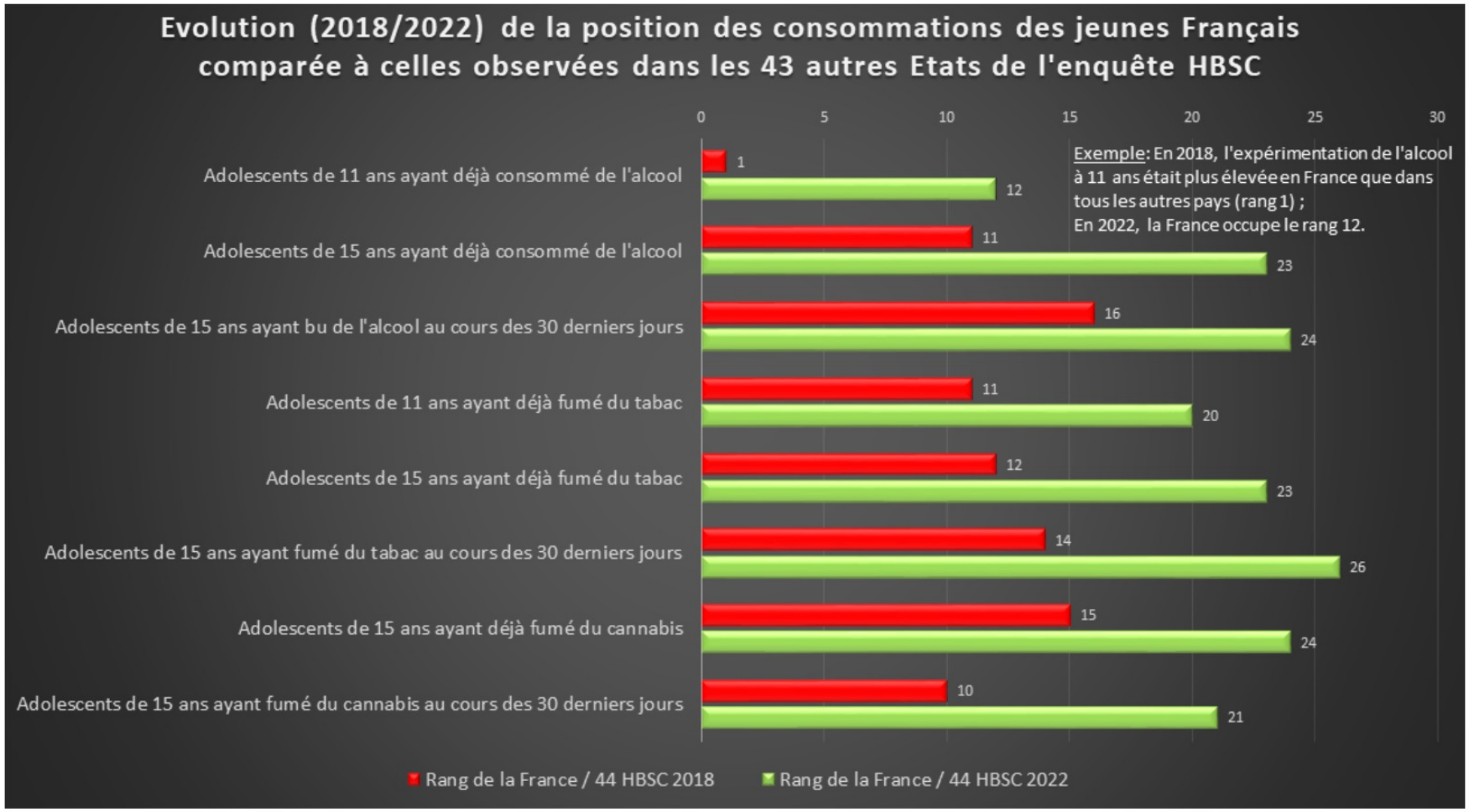


Quantité d'alcool mis en vente par habitant âgé de 15 ans et plus depuis 1961 (en litre d'équivalents d'alcool pur)

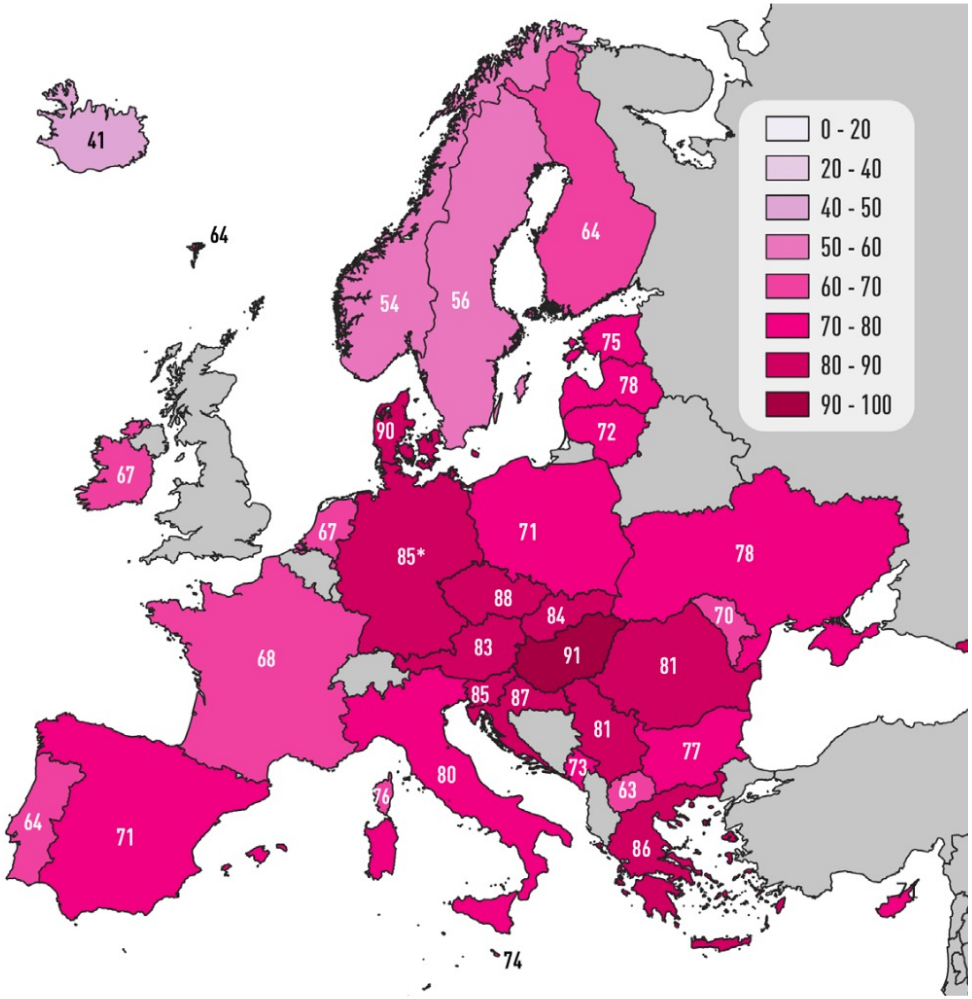


Université Paris Cité

Les jeunes français s'améliorent

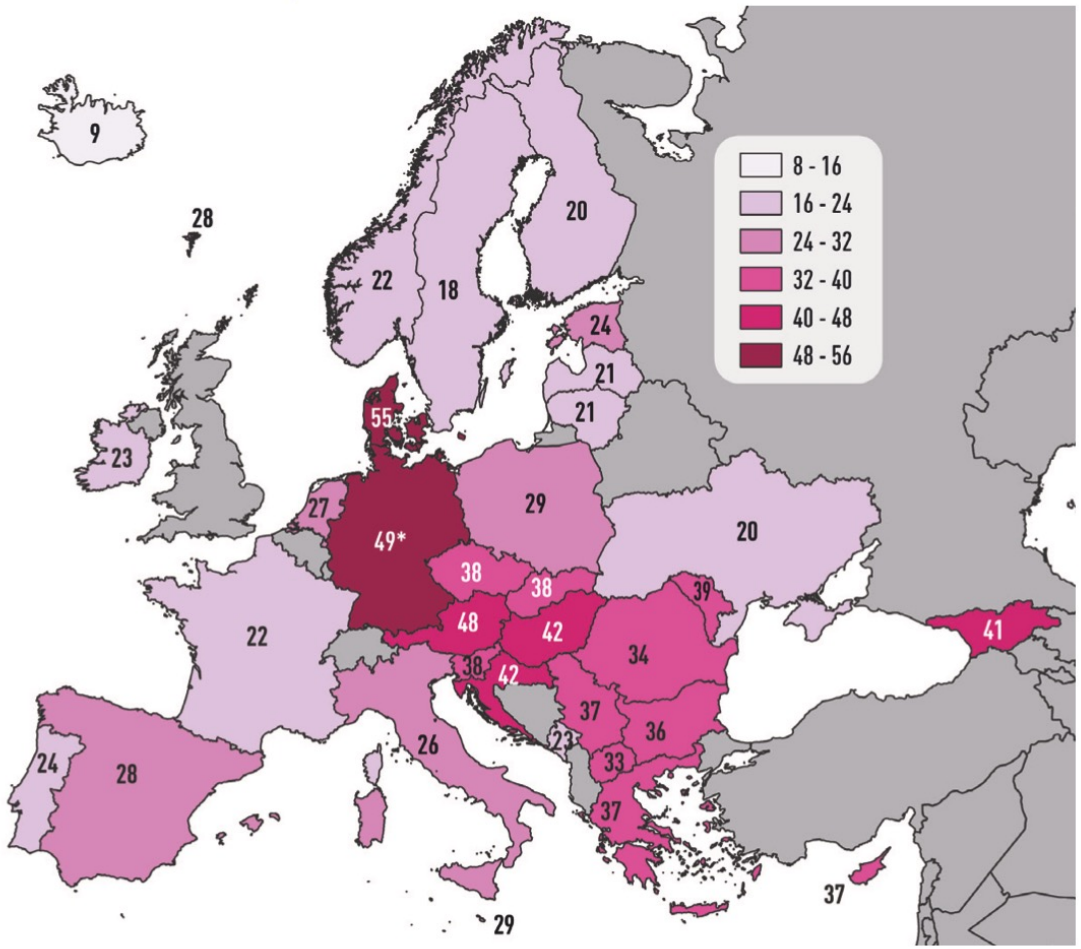


Carte 3. Expérimentation d'alcool à 16 ans en 2024 en Europe (%)



Source : ESPAD 2024, EnCLASS 2024, exploitation OFDT

Carte 4. Niveaux des alcoolisations ponctuelles importantes (API) au cours du mois à 16 ans en 2024 en Europe (%)



Source : ESPAD 2024, EnCLASS 2024, exploitation OFDT

Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

Consommation aiguë

Les effets dépendent du taux d'alcoolémie

Doses	Effets possibles
Dose faible	Sensation de détente, d'euphorie, voire d'excitation. Désinhibition Diminution des réflexes Réduction du champ visuel
Dose plus forte	Ivresse mauvaise coordination des mouvements, élocution troublée, diminution des réflexes et de la vigilance, état de somnolence, etc pertes de mémoire allant jusqu'au trou noir (oubli de ce qui s'est passé la veille, le buveur ayant perdu la capacité de l'enregistrer et de le mémoriser) hypothermie
Très forte dose	Coma éthylique qui, faute de soins, peut provoquer la mort. Le coma éthylique nécessite une hospitalisation en urgence

Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

Consommation aigue

- **Risque majoré d'accident de la voie publique**

Multiplié par 6 pour un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g/l, et par 80 pour un taux supérieur à 2 g/l.
En cause dans près d'1/3 des accidents mortels de la route

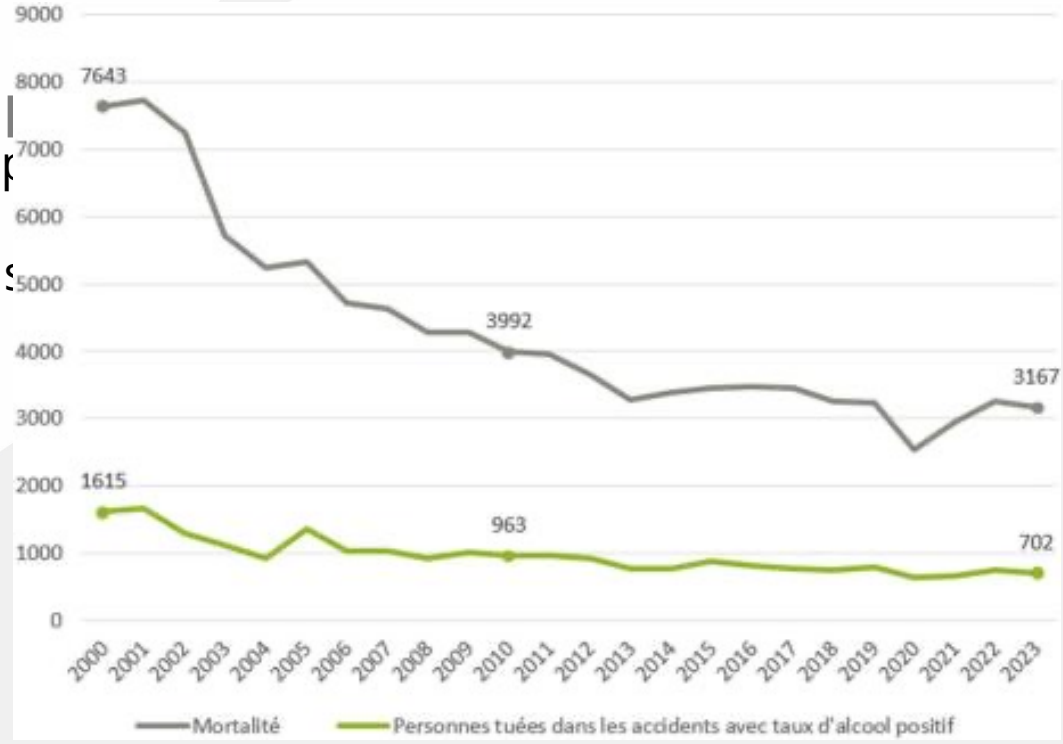
Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

Consommation aigue

- **Risque majoré d'accident de la voie p**

Multiplié par 6 pour un taux d'alcoolémie comp
taux supérieur à 2 g/l.
En cause dans près d'1/3 des accidents mortels



Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

Consommation aigue

- **Risque majoré d'accident de la voie publique**

Multiplié par 6 pour un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g/l, et par 80 pour un taux supérieur à 2 g/l.
En cause dans près d'1/3 des accidents mortels de la route

- **Augmentation des risques psychosociaux**

Auto et hétéro-aggressivité (violences conjugales)
Rapports sexuels non protégés et/non désirés

- **Accidents du travail**

Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

Consommation chronique

- **Cancers**

8% sont attribuables à l'alcool : bouche, larynx, pharynx, œsophage, foie, côlon-rectum, sein

- **Troubles cardiovasculaires** : HTA, AVC, fibrillation auriculaire
- **Cirrhose**
- **Effets sur le cerveau :** mémoire, concentration, atrophie cérébrale et cérébelleuse, dépendance, encéphalopathies, démences, neuropathies …

Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

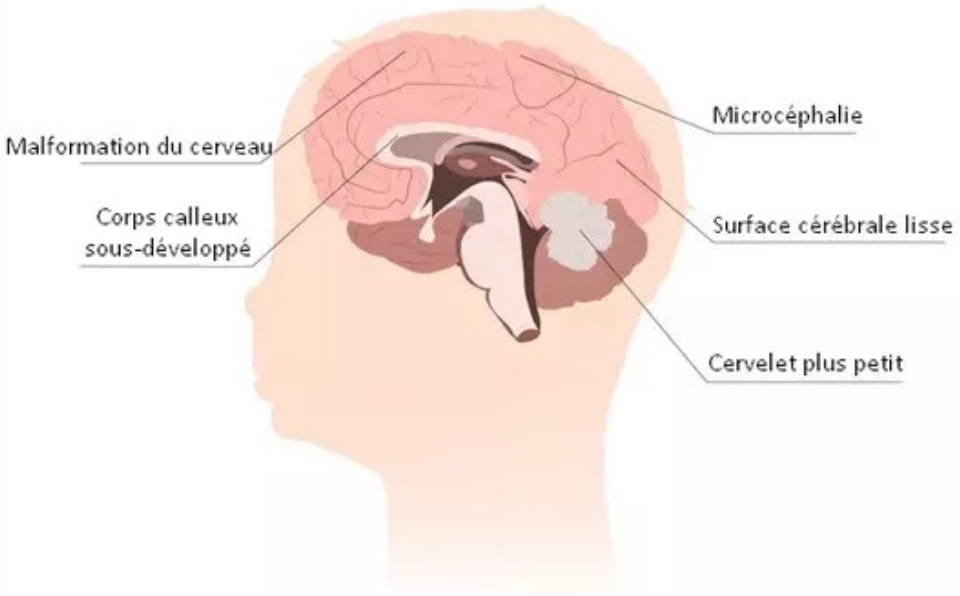
Consommation passive

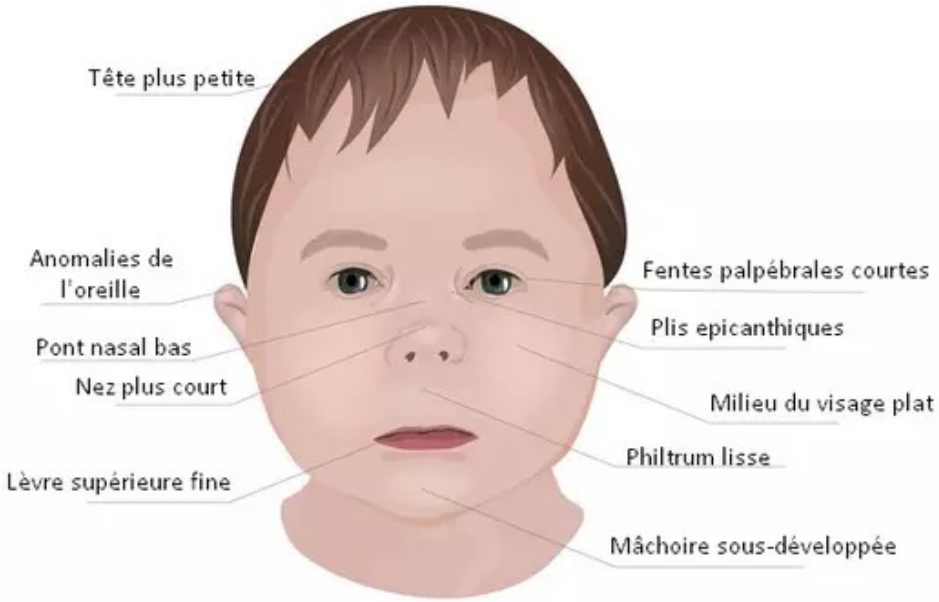
- La consommation d'alcool pendant la grossesse est **la première cause de handicap mental**, d'origine non génétique, chez l'enfant.
- Large spectre de manifestations cliniques : depuis le Syndrome d'Alcoolisation Fœtale (SAF) à des troubles neuro-développementaux isolés.

Par ailleurs, certaines (fausses) croyances demeurent en 2020 :

- 19% déclarent qu'il est conseillé de boire un petit verre de vin de temps en temps pendant la grossesse ;
- 23% pensent qu'il est conseillé de boire un peu de bière pendant la période de l'allaitement.

Effets du syndrome d'alcoolisation foetale sur le cerveau et le visage





Université Paris Cité

Politiques publiques

La législation relative à la lutte contre l'alcoolisme comprend **essentiellement des mesures répressives** alliant fiscalité et ordre public : le commerce et la distribution d'alcool sont réglementés depuis le XIXe siècle :

La Loi du 23 janvier 1873 (JO, 4 février 1873) stipule que l'ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction.

……

Université Paris Cité



IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L'ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.

IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE ("HAPPY HOURS") SANS PROPOSER ÉGALEMENT SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS.

IL EST INTERDIT AUX DEBITANTS DE BOISSONS DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS.

IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.



IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L'ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.

La personne qui délivre la boisson exige du client une preuve de sa majorité, notamment par la production d'une pièce d'identité.

Il est interdit d'offrir de l'alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics.

IL EST INTERDIT DE VENDRE DES BOISSONS ALCOOLIQUES RÉFRIGÉRÉES DANS LES POINTS DE VENTE DE CARBURANT.

IL EST INTERDIT DE VENDRE DES BOISSONS ALCOOLIQUES À EMPORTER, ENTRE 18H ET 8H, DANS LES POINTS DE VENTE DE CARBURANT.

IL EST INTERDIT DE VENDRE À CRÉDIT DES BOISSONS ALCOOLIQUES.

IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.



IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L'ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.

IL EST INTERDIT DE VENDRE À CRÉDIT DES BOISSONS ALCOOLIQUES*.

IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.

Université Paris Cité

Recommandations : Nouveaux repères 2019



Santé publique France recommande ainsi de réduire la consommation d'alcool sur les bases suivantes :

- **Pas plus de 10 verres par semaine**
- **Pas plus de 2 verres par jour**
- **Des jours sans alcool**

Réduire la quantité totale

Boire lentement, en mangeant et en alternant avec de l'eau

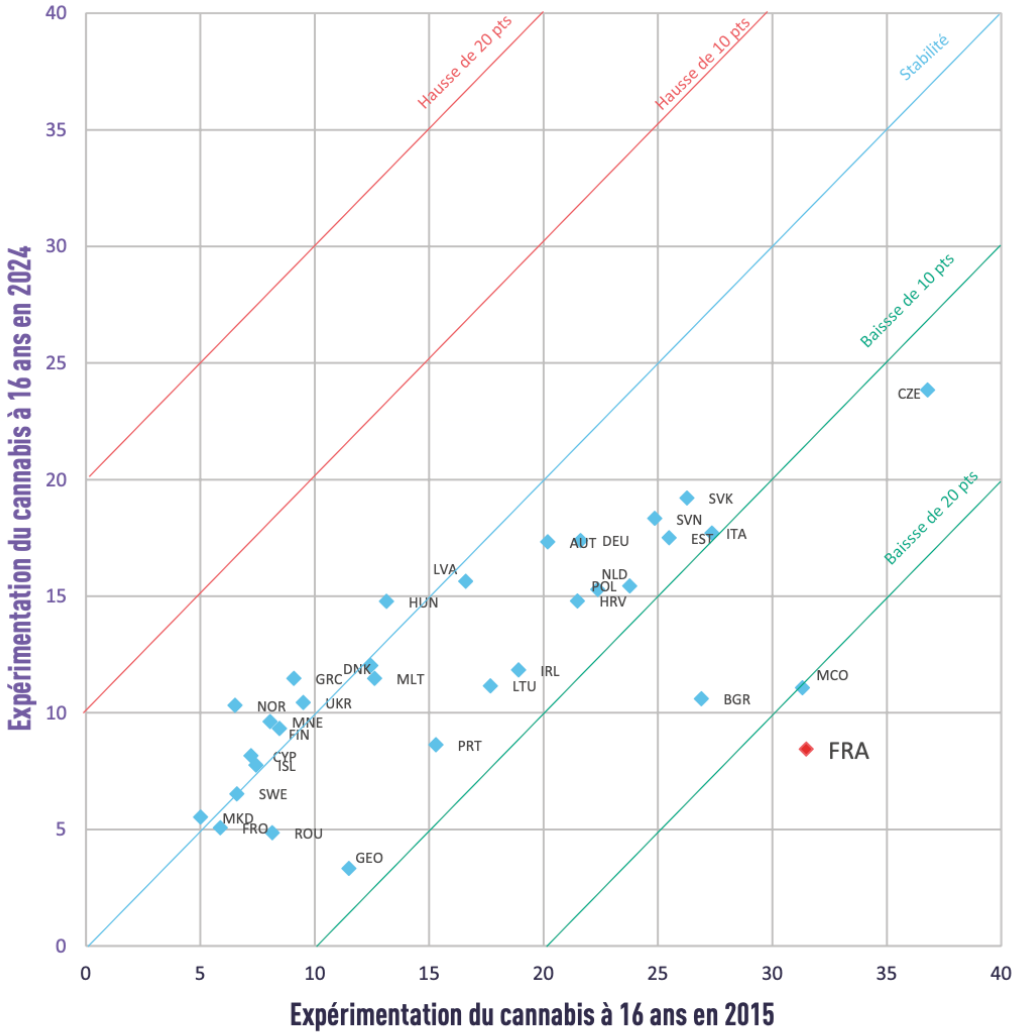
Limiter les lieux et activités à risque

Ne pas consommer si conduite automobile, pratique de sport à risque, certains médicaments, certaines pathologies

Université Paris Cité

Le cannabis

Figure 4. Évolution des expérimentations de cannabis à 16 ans en Europe entre 2015 et 2024 (%)



Sources : ESPAD 2015-2024, EnCLASS 2024, exploitation OFDT

Université Paris Cité

Fardeau socio-économique des drogues

Tableau 3 – Coût social des drogues en 2019

	Alcool	Tabac	Drogues illicites
Nombre de décès	**41 080**	**73 189**	**1 230**
1. Coût externe (2+3+4) (M€)	**98 457 (96,10 %)**	**154 200 (99,02 %)**	**5 277 (68,28 %)**
2. Coût des vies perdues	55 349 (54,02 %)	88 216 (56,65 %)	2 740 (35,45 %)
3. Coût de la perte de qualité de vie	35 949 (35,09 %)	55 674 (35,75 %)	2 123 (27,47 %)
4. Pertes de production	7 159 (6,99 %)	10 310 (6,62 %)	414 (5,36 %)
5. Coût pour les finances publiques (M€) (6+7+8+9)	**3 332 (3,25 %)**	**1 691 (0,82 %)**	**2 042 (26,43 %)**
6. Coût des traitements	7 849 (7,66 %)	16 439 (10,56 %)	760 (9,83 %)
7. Économie de retraites	- 1 256 (-1,23 %)	- 2 845 (- 1,83 %)	- 65 (- 0,85 %)
8. Prévention, répression et dépenses sociales	740 (0,72 %)	778 (0,50 %)	1 348 (17,44 %)
9. Taxation			
10. Effet sur le bien-être* (M€)			
11. Coût social (1+10) (M€)			

102 Milliards **156 Milliards** **8 Milliards**

Note : * la ligne 10 est égale au produit de la ligne 5 par 1,2, soit le coût d'opportunité des fonds publics.

Université Paris Cité

Activité physique et Sédentarité

Les consommations alimentaires, l'activité physique et la sédentarité sont des facteurs de risque de nombreuses maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'obésité ou encore le diabète de type 2.

Université Paris Cité

Définitions

Activité physique

L'activité physique se définit comme « tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques et qui entraîne une dépense d'énergie supérieure à la dépense de repos ».

Elle englobe l'activité physique effectuée durant les loisirs, les jeux, l'éducation physique, les sports, les déplacements, les activités professionnelles, ou encore les tâches ménagères.

Toute activité physique a des effets bénéfiques sur la santé.

Université Paris Cité

Définitions

Sédentarité

La sédentarité se définit par tout comportement caractérisé par une dépense énergétique inférieure à 1,6 METs (Équivalent métabolique ou Metabolic Equivalent Task) incluant la position assise ou allongée.

Elle est à considérer de manière indépendante de l'(in)activité physique. Il est possible d'être physiquement actif tout en accumulant des comportements sédentaires et ce, sur une même journée.

La sédentarité est ainsi un facteur de risque spécifique des maladies non transmissibles qui se surajoute à l'inactivité physique.

Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

En 2009, l'inactivité physique a été identifiée comme étant **le quatrième facteur de risque des maladies non transmissibles**, impliquée dans **plus de 3 millions des morts évitables**.

L'inactivité physique est responsable dans le monde :

- 6 à 9% de la mortalité toutes causes
- 6% des maladies coronariennes
- 7% du diabète de type 2
- 10% des cancers du sein
- 10% des cancers du côlon
- 9% des morts prématurées seraient attribuables au seul fait d'être inactif

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban) 2014-2016. Volet nutrition. Chapitre Activité physique et sédentarité. 2e édition / p. 10

Université Paris Cité

Conséquences sanitaires

Le fait de passer plus de 3 heures par jour en position assise serait responsable de 3,8% de la mortalité toutes causes.

Chaque heure de plus passée assis au-delà de 7 heures par jour augmente de 5% le risque de mortalité toutes causes après ajustement sur l'activité physique.

Chau JY, Grunseit AC, Chey T, Stamatakis E, Brown WJ, Matthews CE, et al. Daily sitting time and all-cause mortality: a meta-analysis. PLoS One. 2013;8(11):e80000.

Tableau 1

Prévalence des niveaux d'activité physique et de sédentarité des hommes et femmes de France hexagonale, Baromètre de Santé publique France, 2021

	Hommes		Femmes		p[a]
	%	[IC95%]	%	[IC95%]	
Activité physique					
Atteinte des recommandations d'AP[b]	72,9	[71,8-73,9]	59,3	[58,2-60,4]	<0,001
Atteinte des recommandations de RM[c]	31,1	[30,0-32,2]	20,2	[19,3-21,1]	<0,001
Sédentarité					
Sédentarité élevée (temps assis >7h/jour)	23,3	[22,3-24,2]	22,2	[21,3-23,0]	0,09
Temps écran de loisirs >3h/jour	39,3	[38,2-40,5]	39,0	[37,9-40,1]	0,67
Rupture de sédentarité au moins toutes les 2 heures	91,4	[90,7-92,1]	92,0	[91,4-92,6]	0,16
Cumul des facteurs de risque					
Cumul d'une AP insuffisante et d'une sédentarité élevée	8,6	[8,0-9,2]	9,9	[9,3-10,6]	<0,01

AP : activité physique ; RM : renforcement musculaire ; IC95% : intervalle de confiance à 95%.

[a] p-value de la comparaison entre hommes et femmes (test du Chi2 de Pearson avec correction de Rao-Scott).

[b] Recommandations d'AP : pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'AP aérobie d'intensité modérée ou au moins 75 à 150 minutes d'AP aérobie d'intensité soutenue ou une combinaison équivalente d'AP d'intensité modérée ou soutenue par semaine.

[c] Recommandation de RM : pratiquer des activités de RM au moins deux fois par semaine.

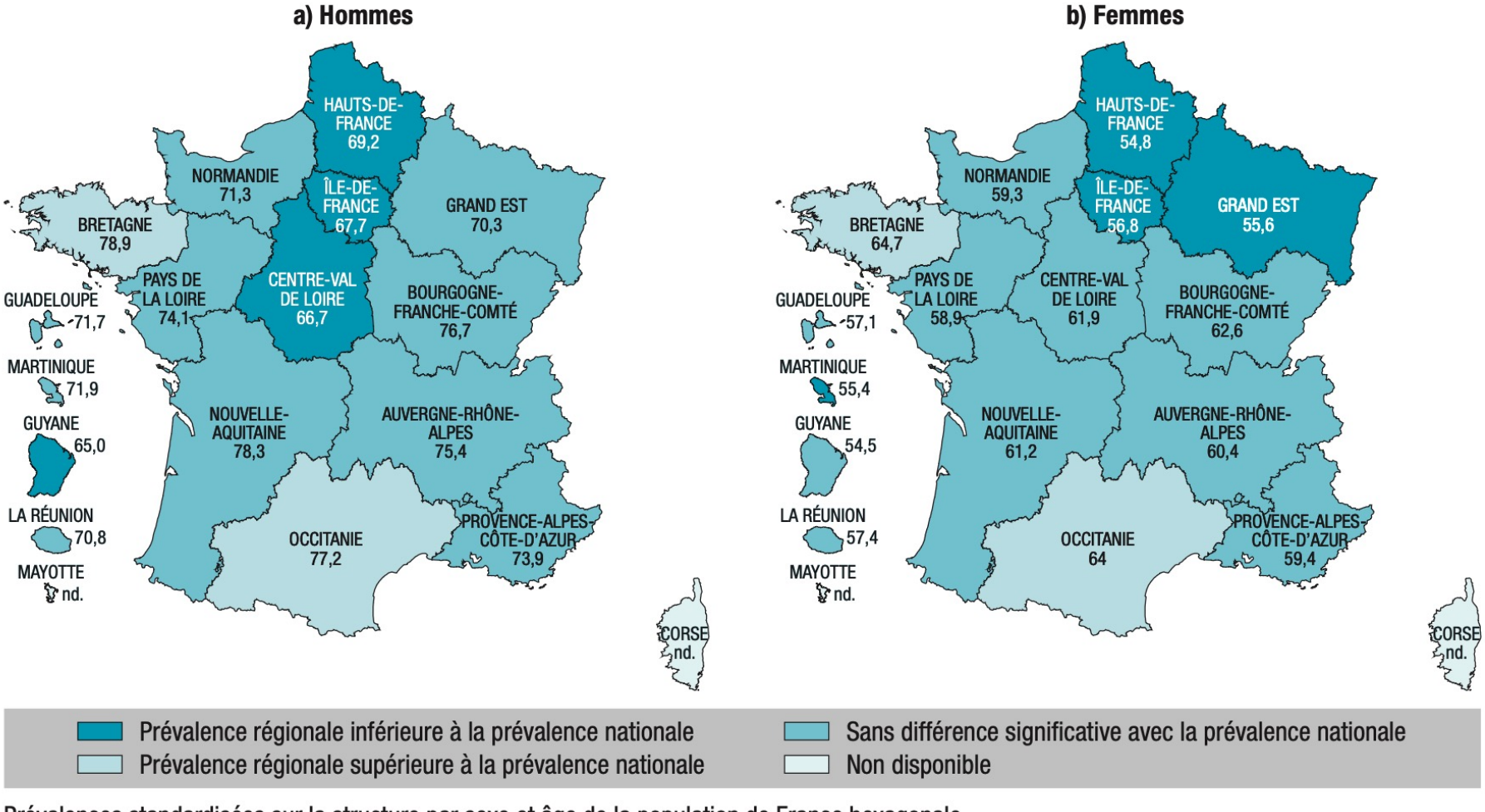
Tableau 2

Facteurs sociodémographiques associés à l'atteinte des recommandations d'activité physique en France hexagonale, Baromètre de Santé publique France, 2021

	Hommes (n=11 237)				Femmes (n=12 806)			
	%	ORa	[IC95%]	p	%	ORa	[IC95%]	p
Âge								
18-24 ans	78,8	1,7	[1,3-2,3]	<0,001	61,7	0,9	[0,7-1,1]	0,36
25-34 ans	74,8	1,2	[1,0-1,5]	0,03	59,4	0,8	[0,7-1,0]	0,05
35-44 ans	75,2	1,3	[1,0-1,5]	0,01	58,4	0,9	[0,7-1,0]	0,08
45-54 ans (réf.)	70,5	- 1 -			61,6	- 1 -		
55-64 ans	71,8	1,0	[0,9-1,3]	0,70	57,7	0,8	[0,7-1,0]	0,03
65-74 ans	72,0	0,8	[0,6-1,1]	0,15	62,6	1,0	[0,8-1,2]	0,91
75-85 ans	65,4	0,6	[0,4-0,8]	0,001	51,9	0,7	[0,5-0,8]	<0,001
Niveau de diplôme								
<Bac	70,5	0,9	[0,7-1,0]	0,04	53,8	0,7	[0,6-0,8]	<0,001
Bac (réf.)	75,6	- 1 -			63,0	- 1 -		
>Bac	74,8	1,0	[0,9-1,2]	0,65	64,5	1,1	[1,0-1,3]	0,06

Figure 1

Prévalence d'atteinte des recommandations d'AP par région chez les hommes et chez les femmes en France hexagonale et dans les DROM en 2021



Prévalences standardisées sur la structure par sexe et âge de la population de France hexagonale.
AP : activité physique ; DROM : départements et régions d'outre-mer.

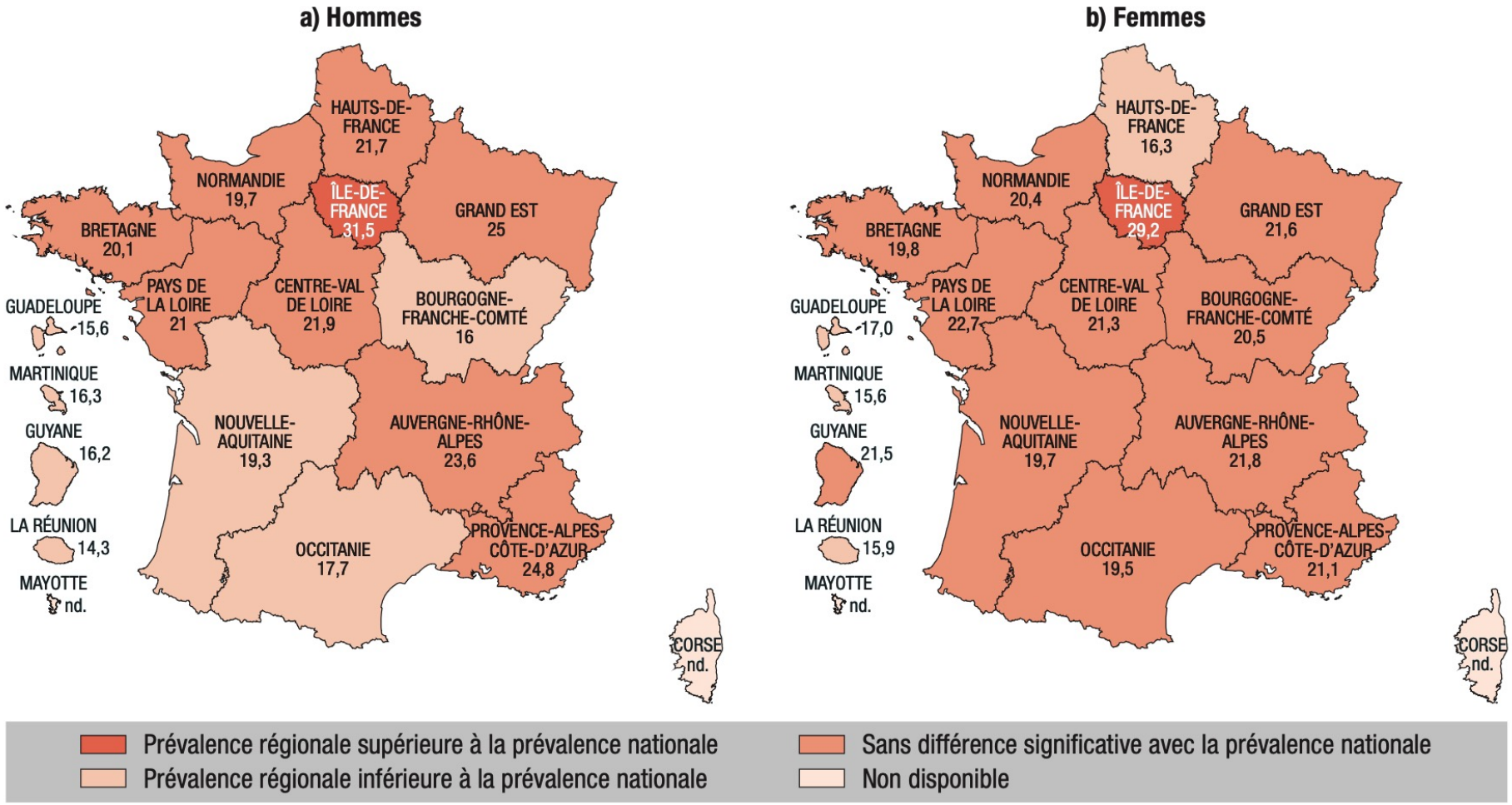
Tableau 3

Facteurs sociodémographiques associés à une sédentarité élevée (temps assis supérieur à sept heures par jour) en France hexagonale, Baromètre de Santé publique France, 2021

	Population (n=23 976)			
	%	ORa	[IC95%]	p
Âge				
18-24 ans	38,6	1,1	[0,9-1,3]	0,32
25-34 ans	29,9	0,9	[0,8-1,0]	0,16
35-44 ans	27,7	0,9	[0,8-1,1]	0,39
45-54 ans (réf.)	27,0	- 1 -		
55-64 ans	17,5	0,8	[0,7-1,0]	0,01
65-74 ans	7,5	0,6	[0,5-0,8]	0,001
75-85 ans	8,4	0,8	[0,6-1,1]	0,15
Niveau de diplôme				
<Bac	11,9	0,7	[0,6-0,8]	<0,001
Bac (réf.)	23,9	- 1 -		
>Bac	36,7	2,0	[1,8-2,3]	<0,001
Situation professionnelle				
Travail (réf.)	29,7	- 1 -		
Études	48,6	2,0	[1,7-2,4]	<0,001
Chômage	15,0	0,5	[0,4-0,6]	<0,001
Retraité	7,6	0,3	[0,2-0,4]	<0,001
Autres inactifs	11,0	0,4	[0,3-0,5]	<0,001

Figure 2

Prévalence de la sédentarité élevée (temps passé assis supérieur à sept heures par jour) par région chez les hommes et chez les femmes en France hexagonale et dans les DROM en 2021



Prévalences standardisées sur la structure par sexe et âge de la population de France hexagonale.
DROM : départements et régions d'outre-mer.

Université Paris Cité

Recommandations mondiales

Pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans, « d'accumuler au moins 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue ».

Pour les adultes, de « pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue.

Pour obtenir des bénéfices sanitaires majorés, les individus doivent donc non seulement **être actifs, mais également limiter leurs comportements sédentaires** afin de prévenir l'apparition de certaines maladies non transmissibles et d'en limiter la morbidité .

Universi
Paris Cit

Haut Conseil de la Santé Publique

LE HCSP AVIS ET RAPPORTS LA REVUE *ADSP* Canicule

accueil / avis et rapports / Recommandations pour l'élaboration du 5e programme national nutrition santé (PNNS)

Recommandations pour l'élaboration du 5e programme national nutrition santé (PNNS)

Freins	Leviers	Freins	Leviers
Paresse, autres centres d'intérêt	Se fixer un objectif, lien avec un sport	Etat et nombre des infrastructures	Plus d'AP à l'école, attitude positive de l'enseignant, EPS plus ludique
Surpoids, problème de santé	Aptitude et condition physiques		
Combien et quand	Sens de l'AP, alimentation, sommeil	Expérience et personnalité de l'entraîneur, coût	Expérience et personnalité de l'entraîneur, activité ludique
Echec, inexpérience	Sentiment de réussite, compétences		
	Santé et apparence		
Facteurs associés à l'adolescent		**Environnement physique**	
Environnement social et relationnel		**Facteurs extérieurs**	
Activité de l'entourage	Activité de l'entourage	Travail scolaire, fatigue, manque de temps	Réseaux sociaux, Activité en ligne
Pression parentale et statut socio-économique	Soutien et encouragement de la famille et des proches	Réseaux sociaux, fatigue	Proximité des infra-structures sportives
Mauvaise expérience en sport collectif	Soutien et accompagnement des amis	Manque d'espaces et de clubs dédiés	Modèles sportifs, personnalités (influenceurs), promotion du sport
Freins	Leviers	Freins	Leviers

Figure 9-Freins et leviers pour l'activité physique des adolescents (Modifiée et adaptée à partir des travaux de Martins et al., 2021 et Karchynskaya et al., 2024)[112,113]

Université Paris Cité

Nutrition

La nutrition est un facteur de protection ou de risque des maladies non transmissibles les plus répandues en France, qu'il s'agisse du cancer, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, de l'ostéoporose ou du diabète de type 2. *(cf. cours problèmes de santé)*

Etude ESTEBAN 2014-2015 sur les consommations alimentaires :

- Part des acides gras saturés trop élevée
- Faible consommation de poissons et produits de la pêche
- Faible consommation de fibres
- Trop forte consommation de sel
- Consommation de boissons sucrées élevée
- Inégalités sociales de consommation même si tendance à la diminution de l'écart liée aux modifications d'alimentation des catégories les plus diplômées

Université Paris Cité

Quelques chiffres sur l'alimentation en France

Insuffisance de fibres

89,7% DES ADULTES — **de 18 à 54 ans n'atteignent pas les recommandations fixées à 25 g de fibres par jour.**

En cause, une consommation trop faible :
- de produits céréaliers notamment complets (plus de 60 % des adultes ne les incluent pas dans leur alimentation) ;
- de légumes secs (plus de 85 % des adultes ne satisfont pas la recommandation) ;
- de fruits et légumes (72 % des adultes en consomment moins de 5 par jour)[2, 3].

Trop d'acides gras saturés, pas assez d'oméga 3

83% DES ADULTES — dépassent le seuil recommandé des apports en acides gras saturés (< 36 % des apports en lipides totaux)[2].

Les apports moyens en acides gras oméga 3 (ALA, DHA, et EPA) des adultes sont environ deux fois trop faibles[4].

Trop de charcuterie

63% DES ADULTES — dépassent la limite des 150g de charcuterie par semaine[2, 3].

Consommation trop importante de sel

90% DES ADULTES — dépassent la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé de 5 g de sel par jour[2, 3].

Trop de produits sucrés

40% DES ADULTES — ont une consommation de produits sucrés supérieure aux recommandations.

30 % des adultes dépassent un verre par jour de boissons sucrées[2, 3].



https://www.youtube.com/watch?v=GrXpnKx7dTM&ab_channel=Sant%C3%A9publiqueFrance

Pour un mode de vie plus équilibré, commencez par

Augmenter ↗

- Les fruits et légumes
- Les légumes secs : lentilles, haricots, pois chiches, etc.
- Les fruits à coque : noix, noisettes, amandes non salées, etc.
- Le fait maison
- L'activité physique

Aller vers ↱

- Le pain complet ou aux céréales, les pâtes, la semoule et le riz complets
- Les poissons gras et maigres en alternance
- L'huile de colza, de noix, d'olive
- Une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée
- Les aliments de saison et les aliments produits localement
- BIO Les aliments bio

Réduire ↘

- L'alcool
- Les produits sucrés et les boissons sucrées
- Les produits salés
- La charcuterie
- La viande : porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats
- Les produits avec un Nutri-Score D et E
- Le temps passé assis

Chaque petit pas compte et finit par faire une grande différence

MANGERBOUGER.FR

Santé publique France

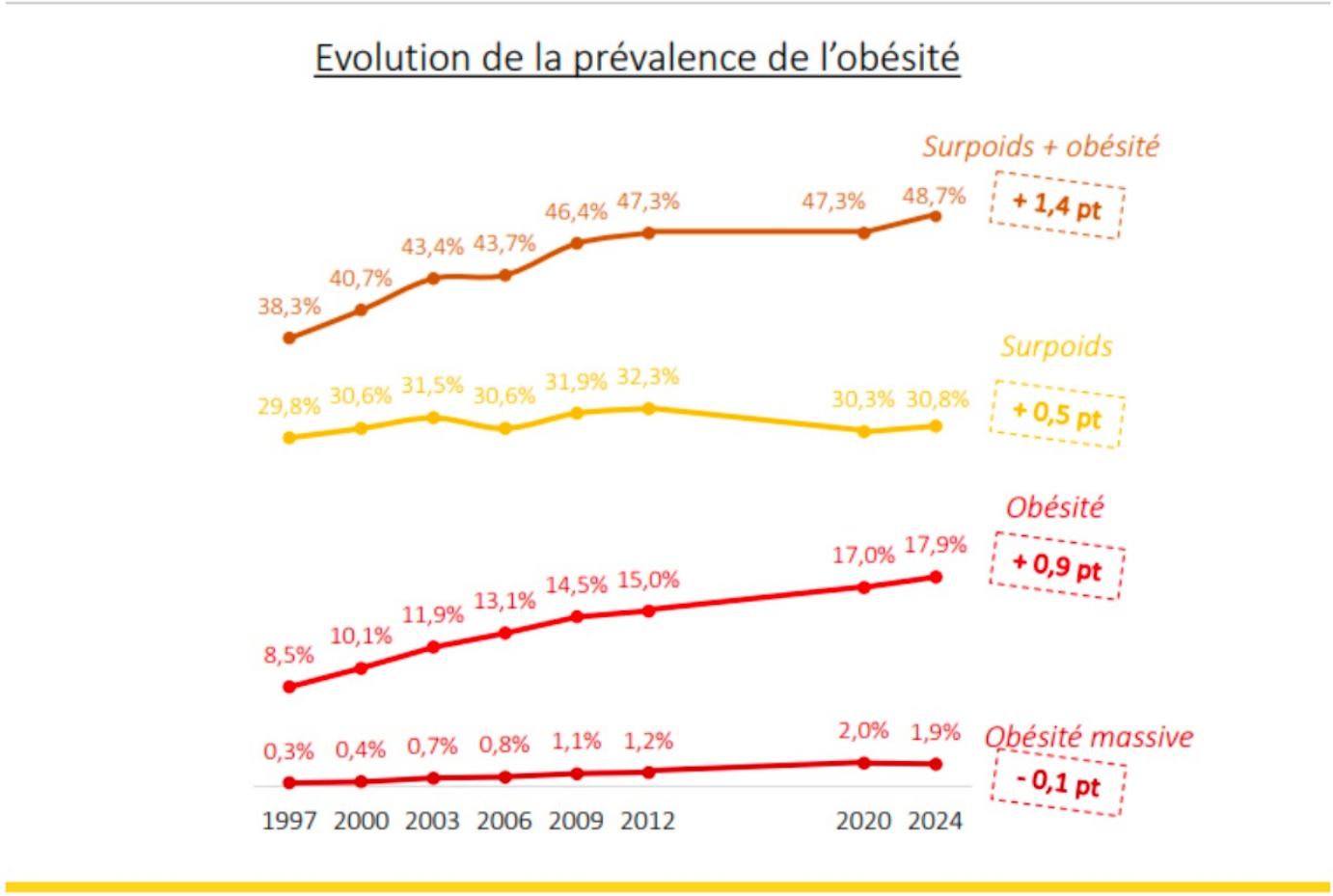


Figure 1-Évolution de la prévalence de l'obésité (Etude OFEO ; Odoxa/ligue contre l'obésité 2025)

Université Paris Cité

Nutrition

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a été mis en place dès janvier 2001, reconduit en 2006, 2011, 2017 pour améliorer la situation nutritionnelle de la population générale. **Le prochain (5ème) est en cours d'élaboration**

Les objectifs de santé publique du PNNS portent à la fois sur les consommations alimentaires, l'activité physique et la sédentarité, ainsi que sur divers marqueurs de l'état nutritionnel.

Ils répondent à 4 axes qui sont :

- la réduction de l'obésité et du surpoids dans la population,
- l'augmentation de l'activité physique et la diminution de la sédentarité à tous les âges,
- l'amélioration des pratiques alimentaires et des apports nutritionnels, notamment dans les populations à risque,
- la réduction de la prévalence des pathologies nutritionnelles.

Université Paris Cité

Santé sexuelle

Définition de l'OMS en 2002 - la santé sexuelle est :

« Un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité.

Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle a besoin **d'une approche positive et respectueuse** de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute **sécurité et sans contraintes, discrimination ou violence**. »

Université Paris Cité

Les indicateurs globaux de la santé sexuelle de la population française sont satisfaisants par rapport à de nombreux pays : les principaux indicateurs des objectifs d'une bonne santé sexuelle sont partiellement atteints :

- **L'autonomie** (avoir la capacité de concevoir des enfants et la liberté de décider d'en concevoir) : 80% des femmes de 15 à 49 ans utilisent un moyen de contraception ;

- **La sécurité** : plus de 80% des jeunes de 15 à 25 ans utilisent des préservatifs lors des premiers rapports sexuels ;

- **La satisfaction** : 88% des femmes comme des hommes ont jugé « très bonne » ou « satisfaisante » leur vie sexuelle ;

Université Paris Cité

Santé sexuelle

Toutefois, le constat

un tiers des grossesses reste non prévu et aboutit 6 fois sur 10 à une IVG
une augmentation de 10% d'IST chez les 15-24 ans entre 2012 et 2014 et chez les populations vulnérables

près de **6000 nouvelles séropositivités** en 2015, même si l'épidémie du VIH est globalement stable depuis 2007

la couverture vaccinale VHB est insuffisante chez les adolescents et les adultes exposés (43% des adolescents de 15 ans (2009)) et **la couverture vaccinale HPV est également trop faible** (28.3% des jeunes femmes de 16 ans)

Université Paris Cité

Santé sexuelle

Le constat

une femme sur 7 et **un homme sur 25** déclarent avoir subi au moins une forme de **violence sexuelle** au cours de leur vie

des **discriminations sociales**, notamment les inégalités entre les femmes et les hommes, **homophobi**e (31% des HSH ont été victimes d'actes homophobes au cours des 12 derniers mois (2012)

les **difficultés liées à la sexualité** varient de 35 à 65% en fonction de l'âge, du sexe.

Université Paris Cité

Santé sexuelle

Les déterminants de la santé sexuelle

- **Champ individuel** : les dimensions physiques/biologiques, les caractéristiques socioéconomiques, les compétences sociales/émotionnelles/relationnelles/ mentales

- **Champ communautaire** : les influences et les impacts directs sur l'individu des milieux : famille, ami.e.s, communauté locale, scolaire, travail et hébergement

- **Champ structurel et contextuel** : les systèmes éducatifs, de santé et socio-sanitaires, l'aménagement du territoire, les médias et techniques de communication et, d'autre part, les contextes politiques, législatifs, économiques, démographiques, socioculturels et culturels

Université Paris Cité

Santé sexuelle

Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030

- **AXE I** : Investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes, dans une approche globale et positive ;
- **AXE II** : Améliorer le parcours de santé en matière d'IST, dont le VIH et les hépatites virales : prévention, dépistage, prise en charge ;
- **AXE III** : Améliorer la santé reproductive ;
- **AXE IV** : Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables ;
- **AXE V** : Promouvoir la recherche, les connaissances et l'innovation en santé sexuelle ;
- **AXE VI** : Prendre en compte les spécificités de l'outre-mer pour mettre en œuvre l'ensemble de la stratégie de santé sexuelle .

Université Paris Cité

Les facteurs de risque comportementaux et donc individuels, ont un poids important sur le risque de décès prématuré et évitable. Ils contribuent pour 40% de l'ensemble des facteurs contribuant à la mortalité prématurée (Schroeder, NEJM, 2007).

Ils constituent des déterminants de la santé objectivés par différents indicateurs : mortalité, mortalité prématurée et évitable, morbidité (maladies chroniques), espérance de vie, qualité de vie, handicap, …

Parmi les objectifs d'une politique de santé, la réduction des décès évitables est un cap important que ce soit en donnant les moyens à chacun de se soigner ou de rester en bonne santé le plus longtemps possible.

Agir sur les déterminants de la santé et donc les facteurs comportementaux est une cible importante que ce soit pour essayer de supprimer/atténuer ceux qui sont responsables d'un sur-risque ou favoriser ceux favorables à une bonne santé. Cela impose de travailler sur les changements de comportement.

Université Paris Cité

Toutefois

« Pourquoi Éric est-il à l'hôpital ? *Parce qu'il a une grave infection à la jambe.*
Pourquoi a-t-il cette infection ? *Parce qu'il s'est coupé gravement à la jambe et qu'elle s'est infectée.*
Mais pourquoi s'est-elle infectée *? Parce que les parents sont négligents*
Mais pourquoi cela s'est-il produit ? *Parce qu'il jouait dans le parc à ferraille près de l'immeuble où il habite, et qu'il est tombé sur un morceau d'acier tranchant qui s'y trouvait.*
Mais pourquoi jouait-il dans un parc à ferraille *? Parce qu'il n'a pas écouté ses parents qui lui avaient interdits de jouer dans le parc*

Blaming the victime

Tout repose sur les comportements individuels !

Ce qui est réducteur en ce qu'il néglige les forces sociales qui sont à l'origine des comportements ou habitudes de vie nocifs, caractéristiques de certains groupes et pas seulement des individus qui les composent.

Université Paris Cité

« Pourquoi Éric est-il à l'hôpital ? Parce qu'il a une grave infection à la jambe.
Pourquoi a-t-il cette infection ? Parce qu'il s'est coupé gravement à la jambe et qu'elle s'est infectée.
Pourquoi elle s'est infectée ? Parce que les parents n'ont pas de couverture sociale
Mais pourquoi cela s'est-il produit ? Parce qu'il jouait dans le parc à ferraille près de l'immeuble où il habite, et qu'il est tombé sur un morceau d'acier tranchant qui s'y trouvait.
Mais pourquoi jouait-il dans un parc à ferraille ? Parce que son quartier est délabré. Beaucoup d'enfants jouent là sans surveillance.
Mais pourquoi habite-t-il ce quartier ? Parce que ses parents ne peuvent se permettre mieux. Parce que son père est sans emploi et que sa mère est malade.
Mais pourquoi son père est-il sans emploi ? Parce qu'il n'est pas très instruit et qu'il ne peut trouver un emploi.

Blaming the society

Nécessité de prendre en compte le rôle des déterminants sociaux et économiques individuels tels que la faiblesse des revenus ou la mauvaise qualité du support social et du logement

Université Paris Cité

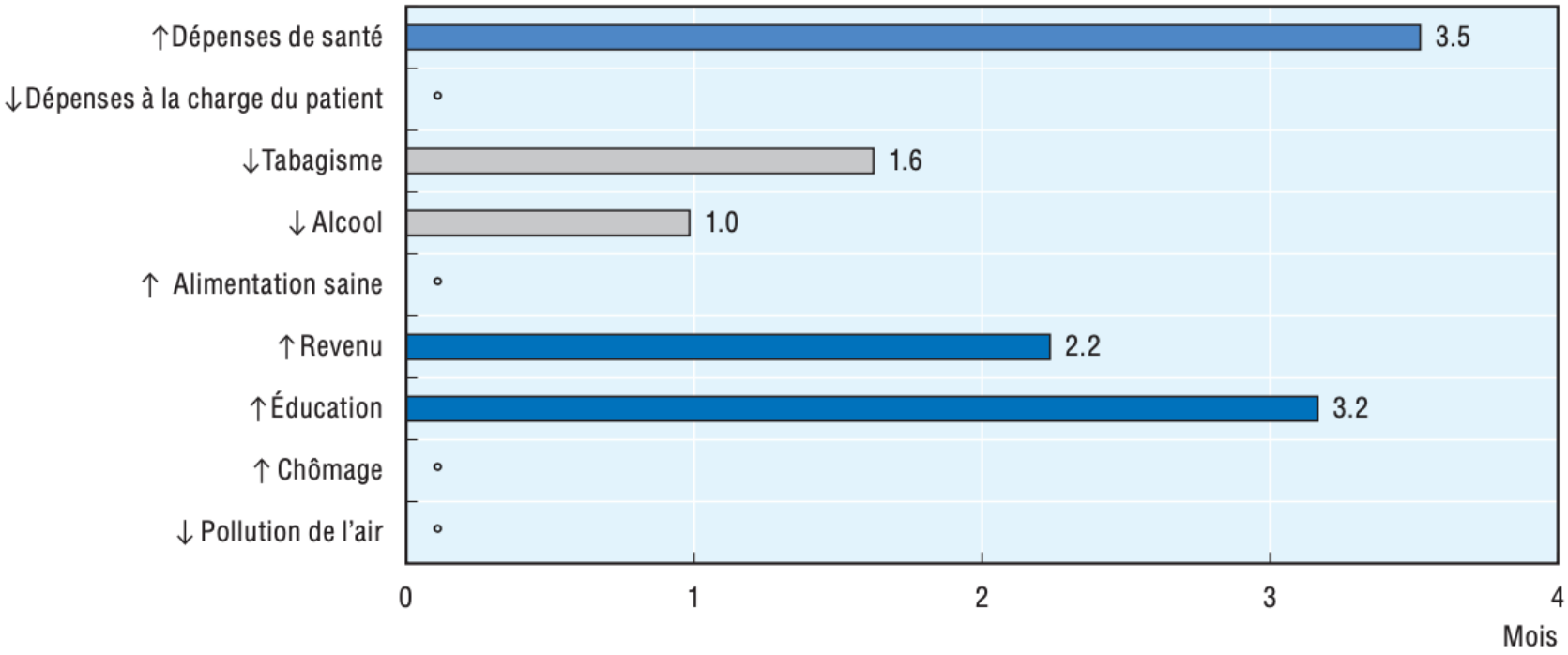
Cela pose les questions :

- **De l'égalité des individus** face aux comportements individuels à risque et favorables à la santé
- **Le poids des inégalités sociales** sur ces comportements et les inégalités de santé qui en résultent (cf. cours de Morgane Michel)
- **Des normes** de comportements et de bonne santé diversement partagées entre les groupes sociaux
- **Avec un risque de stigmatisation**, c'est-à-dire de mauvaises images liées aux comportements, possiblement révélateurs d'une infériorité morale (fumer, boire, …)

Cela implique de **travailler plus globalement sur les différentes dimensions de la santé** et notamment sur la **vision positive** qui promeut le bien-être, le renforcement des compétences et l'autonomie des personnes sans négliger les déterminants sociaux de la santé.

Graphique 2.3. **Allongement de l'espérance de vie associé à une variation de 10 % des principaux déterminants de la santé**

Analyse fondée sur 35 pays de l'OCDE pour la période 1995-2015



Note : ° correspond à une influence quasi-nulle.

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/888933606623

Université Paris Cité

Panorama de la santé OCDE 2017

*« une **action coordonnée** des ministères de la santé et de ceux responsables de l'éducation, de l'environnement, du revenu et de la protection sociale offrirait de grandes possibilités d'améliorer la santé.*

*Des mesures intersectorielles portant sur les comportements liés à la santé en feraient partie. À cet égard, le cadre de l'OMS sur **l'intégration des questions de santé dans toutes les politiques publiques** permet aux pays de prendre systématiquement en compte les implications, pour la santé, des politiques publiques menées dans tous les secteurs (OMS, 2013). »*